1. (IDECAN - 2024 - CBMMG - Enfermeiro Emergencista) É um estado de hipoperfusão de órgãos, com resultante disfunção celular e morte. Os mecanismos podem envolver volume circulante diminuído, débito cardíaco diminuído e vasodilatação, às vezes com derivação do sangue para não passar pelos leitos capilares de troca.
O enunciado define:
A trauma.
B choque.
C lesão.
D hemorragia.

2. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente) O choque hipovolêmico é definido como volume sanguíneo insuficiente relativo ao tamanho do compartimento intravascular, causado por perda de líquidos, hemorragia interna ou retorno venoso deficiente. Os sinais e os sintomas apresentados pelo paciente incluem:
A Nível de consciência alerta, taquicardia, eupneia e hipotensão.
B Nível de consciência alerta, bradicardia, bradipneia e hipotensão.
C Alteração do nível de consciência, taquicardia, respirações rápidas e superficiais e hipotensão.
D Alteração do nível de consciência, bradicardia, respirações rápidas e superficiais e hipertensão.

3. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente) O choque é o estado de perfusão tecidual inadequada que gera suprimento insuficiente de oxigênio (O2) e nutrientes aos tecidos, além de impedir a remoção dos produtos de excreção celular, caracterizado pelo desequilíbrio entre a perfusão e as necessidades celulares. Dentre os tipos de choque, assinale a alternativa que corresponde ao choque cardiogênico.
A Hemorragia e desidratação.
B Falência da bomba cardíaca.
C Tamponamento pericárdico e embolia pulmonar.
D Resposta do organismo a uma infecção sistêmica.

4. (DECORP - 2025 - Prefeitura de Porto Walter - Enfermeiro) O choque é uma condição grave caracterizada por perfusão tecidual inadequada e disfunção orgânica progressiva. Relacione corretamente os tipos de choque com suas principais características fisiopatológicas.
1. Choque hipovolêmico
2. Choque cardiogênico
3. Choque distributivo
4. Choque séptico
A. Redução da volemia circulante efetiva, levando a hipotensão e taquicardia compensatória.
B. Falha na função cardíaca, resultando em débito cardíaco insuficiente e congestão pulmonar.
C. Resposta inflamatória sistêmica, podendo evoluir para disfunção multiorgânica.
D. Alterações da resistência vascular periférica, com vasodilatação excessiva e redistribuição inadequada do fluxo sanguíneo. A relação correta é:
A 1-A, 2-B, 3-D, 4-C.
B 1-A, 2-D, 3-B, 4-C.
C 1-C, 2-B, 3-D, 4-A.
D 1-C, 2-D, 3-B, 4-A.

5. (Prefeitura de Bombinhas - SC - 2025 - Enfermeiro) Qual a alternativa correta relacionada ao choque.
A Choque anafilático é um estado de choque circulatório que resulta em reação alérgica leve, produzindo vasoconstrição sistêmica e hipovolemia grave.
B O choque resultante do volume intravascular aumentado em decorrência da perda de líquidos é o choque hipovolêmico.
C Choque cardiogênico é aquele decorrente do comprometimento ou da falência do epicárdio.
D Choque séptico é um estado resultante da infecção grave que provoca hipovolemia relativa.

6. (IDECAN - 2024 - CNEN - Enfermeiro) O choque é definido como uma anormalidade circulatória, cuja perfusão orgânica e oxigenação tecidual estão inadequadas. Deve-se reconhecer precocemente sua presença e identificar sua provável causa. São causas que podem levar ao choque hipovolêmico, EXCETO:

A Sangramentos volumosos (exteriorizados ou não).
B Perda de líquido excessiva (diarreia, vômito, poliúria e febre).
C Sequestro líquido – tecidos inflamados (peritonite, colite e *pleuris*).
D Drenagem de grandes volumes de transudato (ascite e hidrotórax).
E Tamponamento cardíaco relacionado ao ferimento penetrante no tórax.

7. (IDECAN - 2014 - EBSERH - Médico Anestesiologista) São causas etiológicas de choque obstrutivo, EXCETO:

A Coarctação da aorta.
B Tamponamento cardíaco.
C Tromboembolismo pulmonar.
D Hipertensão pulmonar primária.
E Ruptura de septo interventricular.

8. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Enfermeiro Emergencista) Leia o enunciado abaixo e responda: "Resulta de uma relativa inadequação do volume intravascular; o volume de sangue circulante é normal. Em alguns casos, o débito cardíaco é alto, mas o fluxo sanguíneo aumentado nas anastomoses arteriovenosas se desvia dos leitos capilares; essa derivação, associada ao transporte de oxigênio celular dissociado, causa hipoperfusão celular (demonstrada por menor consumo de oxigênio). Em outras situações, o sangue se acumula em leitos venosos de capacitância e o débito cardíaco cai." O enunciado se refere:

A Choque hipovolêmico.
B Choque térmico.
C Choque distributivo.
D Choque cardiogênico.
E Choque obstrutivo.

9. (VUNESP - 2024 - EsFCEx - Oficial - Cirurgião Geral) Assinale a alternativa correta em relação ao choque neurogênico.

A A denervação parassimpática provoca sinais e sintomas clínicos semelhantes a hipovolemia.
B Trauma craniano isolado não é uma causa de choque neurogênico.
C O tratamento inicial consiste na administração de drogas vasoativas, visando o restabelecimento dos níveis pressóricos.
D Lesão da espinha torácica pode ocasionar hipertensão pelo aumento do tônus simpático.
E Uma pressão de pulso diminuída é observada nesse tipo de choque.

10. (Aeronáutica - 2025 - CIAAR - Médico da Aeronáutica - Cirurgião Geral) O choque é uma condição crítica que exige reconhecimento e intervenção imediatos na urgência e emergência. A identificação da causa do choque e a aplicação de medidas de suporte avançado de vida são essenciais para reverter o processo e evitar desfechos desfavoráveis. Nesse contexto, assinale a opção <u>incorreta</u>.

A No choque hipovolêmico, há aumento do débito cardíaco e da resistência vascular sistêmica. O tratamento se baseia na reposição volêmica com cristaloides e/ou coloides.
B No choque cardiogênico, há diminuição do débito cardíaco e aumento da resistência vascular sistêmica. O tratamento se baseia em suporte inotrópico e vasodilatadores.
C No choque obstrutivo, há diminuição do débito cardíaco e aumento da resistência vascular sistêmica. O tratamento se baseia no alívio da obstrução e suporte hemodinâmico.
D No choque séptico, há aumento do débito cardíaco e diminuição da resistência vascular sistêmica. O tratamento se baseia em antibioticoterapia e ressuscitação volêmica.

11. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente)Um dos sinais e sintomas apresentados na fase inicial do choque hipovolêmico é a frequência respiratória rápida e profunda. A frequência respiratória aumentada sem sinais de alteração do estado mental se deve à(ao):

A Aumento da frequência cardíaca para que o débito cardíaco se torne normalizado.

B Aumento da secreção de renina, angiotensina e aldosterona para aumentar a pressão arterial.

C Metabolismo anaeróbico e ao acúmulo de ácido lático devido à perfusão inadequada, produzindo acidose metabólica.

D Diminuição do volume corrente pulmonar e, como mecanismo compensatório, ao aumento da frequência respiratória.

12. (FUVEST - 2025 - USP - Técnico em Enfermagem) Durante o atendimento a um paciente em choque hipovolêmico, é importante correlacionar essa condição à fisiologia cardiovascular, para entender a resposta do organismo ao choque. Nesse caso, para compensar a perda de volume sanguíneo por sangramento,

A o sistema neurológico provoca redução da frequência cardíaca e vasodilatação periférica.

B pode ocorrer taquicardia e vasoconstrição.

C aumenta-se a diurese e há liberação do sistema renina-aldosterona.

D há inibição da liberação de adrenalina e noradrenalina.

E há redução de hormônio antidiurético e consequente edema com perda de água.

13. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Enfermeiro Intensivista Pediátrico) Considerando a fisiologia renal no contexto da terapia intensiva pediátrica, marque a alternativa correta sobre os mecanismos de regulação da função renal e a importância do equilíbrio hidroeletrolítico em pacientes críticos pediátricos.

A O transporte ativo de sódio nos túbulos distais, regulado pela aldosterona, promove a retenção de sódio e a excreção de potássio. Esse mecanismo é essencial para o equilíbrio hidroeletrolítico, especialmente em hipovolemia e choque séptico.

B O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) tem um papel crucial no controle do volume extracelular e da pressão arterial, estimulando diretamente a secreção de sódio nos túbulos renais distais para aumentar a excreção urinária e reduzir a pressão arterial.

C A vasopressina (ADH) é liberada em resposta ao aumento da osmolaridade plasmática, atuando nos receptores V2 do túbulo coletor para aumentar a reabsorção de água. Isso previne desidratação severa em pacientes pediátricos críticos.

D Nos túbulos contorcidos proximais, aproximadamente 90% do bicarbonato filtrado é reabsorvido, sendo essa uma etapa fundamental para a regulação do equilíbrio ácido-básico, especialmente em condições de alcalose metabólica associadas à insuficiência renal aguda.

E Em pacientes pediátricos com lesão renal aguda, a redução da filtração glomerular causa acúmulo de ureia e creatinina, além de menor excreção de eletrólitos. A hipocalemia é frequentemente observada devido à secreção tubular reduzida

14. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Enfermeiro Centro Cirúrgico) João, um homem de 56 anos, foi admitido no pronto-socorro com sintomas de desidratação grave após um episódio prolongado de vômitos e diarreia. Ele apresenta sinais de hipotensão (pressão arterial de 80/50 mmHg) e taquicardia (frequência cardíaca de 110 bpm). Durante a avaliação, nota-se que João está confuso e com extremidades frias. Os exames laboratoriais indicam aumento dos níveis de creatinina e ureia no sangue, sugerindo insuficiência renal aguda (IRA). Com base nesse caso clínico, em relação à IRA de causa pré-renal, é correto afirmar que:

A ocorre devido à obstrução urinária nos ureteres ou bexiga.

B resulta da hipoperfusão renal causada por hipovolemia ou choque.

C é uma condição rara, representando menos de 10% dos casos de IRA.

D ocorre devido à lesão direta dos túbulos renais, glomérulos ou vasos.
E está associada à nefrotoxicidade causada por medicamentos, como os anti-inflamatórios.

15. (IDECAN - 2014 - CNEN - Enfermeiro) O pós-operatório (PO) imediato de cirurgia cardíaca é um período complexo que exige da equipe assistencial envolvida no cuidado ao paciente submetido a esse procedimento, conhecimento técnico para garantir, além da segurança ao paciente, a continuidade de sua recuperação. Qual das complicações associa-se a uma disfunção de outro órgão importante regulador do equilíbrio ácido-básico?
A Arritmia.
B Infecção.
C Insuficiência renal.
D Sangramento excessivo.
E Tamponamento cardíaco.

16. (IBFC - 2022 - SES-DF - Médico - Clínica Médica) O comprometimento circulatório em doentes traumatizados pode ser resultado de uma variedade de lesões. Sabe-se que o choque hipovolêmico no paciente traumatizado pode desencadear a tríade letal do trauma, um círculo vicioso que, se não interrompido a tempo, leva o paciente ao óbito. Assinale a alternativa que contém os componentes da tríade.
A Choque hipovolêmico, acidose metabólica e hipotermia
B Acidose metabólica, coagulopatia e hipotermia
C Alcalose metabólica, coagulopatia e hipotermia
D Acidose respiratória, choque hipovolêmico e coagulopatia
E Choque hipovolêmico, acidose metabólica e coagulopatia

17. (Aeronáutica - 2024 - CIAAR - Primeiro Tenente - Farmácia Bioquímica) Analise o caso abaixo, o qual será utilizado para responder à questão.
"Paciente jovem é socorrido por paramédicos após acidente automobilístico. É encontrado no local lúcido, hipocorado e com sinais de choque hemorrágico hipovolêmico. Para estabilizá-lo foi administrada solução fisiológica contendo albumina humana e bicarbonato de sódio."
Considerando o paciente em choque hemorrágico hipovolêmico, logo após o acidente, um distúrbio hidroeletrolítico se instalará devido à perda rápida de sangue. Todos os exames laboratoriais estariam alterados, exceto:
A Aumento da pressão de CO2.
B pH < 7, acidose metabólica.
C pH <7, acidose respiratória.
D Redução do volume sanguíneo, com diminuição no número de hemácias e leucocitose e trombocitose reacionais.

18. (AEVSF/FACAPE - 2025 - Prefeitura de Afrânio - PE - Médico Plantonista) Sobre a assistência do paciente vítima de acidente de trânsito terrestre, é CORRETO afirmar que:
A O cálculo do índice de choque ou Shock index pode ser uma ferramenta para reconhecimento de choque oculto. O índice de choque consiste na divisão da PAS/FC. Um índice de choque > 0,8 ou variação ≥ 0,1 é um sinal de choque oculto e é preditivo de hipotensão pós-intubação, necessidade de transfusão, gravidade do trauma e mortalidade.
B A tríade letal do trauma" caracteriza-se por coagulopatia, hipotermia e acidose e pode ser desencadeada por administração excessiva de cristaloides.
C Todos os pacientes vítimas de traumas se beneficiam da hipotensão permissiva visto que a fluidoterapia agressiva objetivando normotensão pode piorar o sangramento quando foco hemorrágico ainda não foi controlado.
D A sondagem vesical pode ser uma medida importante para o diagnóstico de sangramento retroperitoneal e deve ser sempre realizada já na assistência pré-hospitalar.
E A radiografia AP de pelve é considerada o padrão ouro para diagnosticar todas as lesões possíveis de bacia.

19. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Enfermeiro Centro Cirúrgico) Na avaliação pós-operatória imediata, a identificação precoce de sinais de má perfusão tecidual é essencial para prevenir complicações graves. Um paciente recém-transferido para a Sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA) apresenta os seguintes sinais: pulso filiforme, pressão arterial de 90/60 mmHg, saturação de oxigênio de 92% com oxigênio suplementar, extremidades frias, pálidas e cianóticas, e frequência respiratória de 22 incursões por minuto. Com base nesses achados, assinale a alternativa que indica sinais críticos para perfusão tecidual inadequada.

A Pele pálida, fria ou cianótica, sugerindo má perfusão tecidual.
B Saturação de oxigênio acima de 95%, mostrando boa oxigenação.
C Sudorese leve e temperatura corporal estável, sinalizando condição normal.
D Pulso cheio e regular, indicando boa perfusão.
E Frequência respiratória normal com coloração rosada da pele, indicando boa perfusão.

20. (VUNESP - 2025 - Prefeitura de Itatiba - Enfermeiro) O choque hipovolêmico em queimados é ocasionado por perdas de líquidos que levam à redução crítica na perfusão tecidual secundária à redução de eletrólitos essenciais para o pleno funcionamento do organismo, cursando com alto índice de mortalidade. O enfermeiro deve suspeitar desse tipo de choque se observar sinais como:

A sudorese e obnubilação.
B bradicardia e bradipneia.
C palidez e hipertensão.
D hipertermia e sialorreia.
E oliguria e edema de MMII.

21. (SELECON - 2025 - Prefeitura de Sinop - Enfermeiro) Em um cenário de emergência, um paciente de 50 anos, previamente saudável, apresenta quadro de hipotensão severa, taquicardia, pele fria e pegajosa, além de confusão mental. O médico solicita que a equipe de enfermagem tome as primeiras medidas para estabilização. De acordo com os tipos de choque e com as condutas adequadas, a alternativa que descreve corretamente o tipo de choque e a conduta de enfermagem a ser adotada nesse caso é:

A o paciente apresenta sinais compatíveis com choque hipovolêmico, devido à perda de volume circulatório, logo, a conduta de enfermagem inclui a administração imediata de líquidos intravenosos, monitoramento da pressão arterial e encaminhamento rápido para avaliação médica
B o paciente está em choque distributivo, causado por uma vasodilatação excessiva, logo, a conduta envolve a administração de vasopressores, restrição de líquidos intravenosos e monitoramento rigoroso da oxigenação
C com os sinais apresentados, o paciente está em choque cardiogênico devido à falha do coração em bombear sangue adequadamente, logo, a conduta de enfermagem é iniciar massagem cardíaca imediatamente, além de fornecer oxigênio e líquidos intravenosos
D o paciente está em choque obstrutivo, causado por uma obstrução no fluxo sanguíneo, logo, a conduta deve ser a administração de líquidos intravenosos e uso de vasodilatadores para aliviar a obstrução

22. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Médico Psiquiatria) "Situação relacionada ao choque em que não há inicialmente transtorno de macrocirculação; porém, pode haver taquicardia e retenção de líquidos nos rins com tentativa de manter o equilíbrio hemodinâmico." Trata-se da forma de choque conhecida como:

A Falecial.
B Hipodinâmica.
C Hiperdinâmica.
D Descompensada.

23. (FGV - 2025 - PM-RJ - Cabo Policial Militar Especialista - Técnico em Enfermagem) Na avaliação de um paciente com sinais e sintomas de choque, o profissional de

Enfermagem identificou características de choque hipovolêmico Classe II. Assinale a opção que apresenta um sinal ou sintoma relacionado a esse tipo de choque.
A Pressão de pulso normal.
B Frequência cardíaca = 115 bpm.
C Enchimento capilar < 2 segundos.
D Perda sanguínea de cerca de 1600 mL.
E Frequência respiratória > 40 mpm.

24. (FGV - 2024 - Prefeitura de Caraguatatuba - Técnico de Enfermagem) De acordo com a classificação do choque hipovolêmico associado à perda sanguínea aguda, um paciente adulto com choque Classe II apresenta uma perda sanguínea
A menor que 500mL.
B entre 500 e 750mL.
C entre 750 e 1500mL.
D entre 1500 e 2000mL.
E acima de 2000mL.

25. (FGV - 2024 - SES - Técnico em Enfermagem) Um paciente com choque hipovolêmico Classe I apresenta, entre outros sinais e sintomas,
A pressão arterial diminuída.
B pressão de pulso aumentada.
C frequência cardíaca < 100.
D frequência respiratória entre 20 e 30rpm.

26. (Prefeitura de Bauru - SP - 2025 - Médico Cirurgião) Homem de 37 anos de idade, vítima de queda de moto após choque em alta velocidade com um carro, é trazido ao pronto socorro. Apresenta-se com vias aéreas pérvias, murmúrios vesiculares presentes e simétricos, FR de 30 ipm, FC de 125 bpm, PA de 90 x 50 mmHg. Apresenta ainda sinais de fratura em face, antebraço direito e perna direita. Dor à palpação da bacia e distensão abdominal, sem outras alterações. Em relação a classificação do choque a indicação ou tratamento:
A Choque classe III, cristalóide e sangue.
B Choque classe III, sangue, apenas.
C Choque classe IV, cristaloíde e sangue.
D Choque classe IV, sangue, apenas.

27. (IADES - 2018 - SES-DF - Médico - Cirurgia Geral Trauma) Determinado paciente de 65 anos de idade e 70 kg, sofreu um trauma perfurante abdominal após ferimento por arma de fogo. Ele encontra-se na emergência e está acordado, lúcido, conversando, ventilando em ar ambiente. Nega outros tipos de trauma, além do ferimento no abdome. Após descartar lesões de via aérea e tórax, identifica-se que o paciente apresenta as extremidades quentes, bem perfundidas, com uma frequência cardíaca de 130 bpm, pressão arterial de 120 mmHg X 80 mmHg e o restante dos sinais vitais estáveis. O abdome está distendido, tem dor e defesa à palpação, com sinais de irritação peritoneal. Revela uma lesão perfurante com orifício de entrada em hipocôndrio direito, sem orifício de saída. O exame neurológico mostra-se normal e não existem outras alterações no exame físico geral. Em relação à avaliação desse paciente hipotético, referente à letra "C" do ABCDE do trauma (circulação), é correto afirmar que ele
A está em um quadro de choque hemorrágico classe II e tem indicação de ressuscitação volêmica inicialmente.
B está em choque hemorrágico grau IV, de provável origem abdominal, e a transfusão sanguínea é necessária inicialmente.
C tem choque neurogênico, e a ressonância de crânio está indicada.
D tem o estado hemodinâmico classificado como choque grau I, situação em que os níveis de frequência cardíaca aumentam, a pressão arterial é normal, e a diurese é reduzida.
E tem indicação de droga vasoativa, e o estado hemodinâmico dele permite classificá-lo como choque grau III.

28. (FGV - 2022 - Prefeitura de Manaus - AM - Condutor de Motolância) Ao socorrer uma vítima de atropelamento, o profissional de saúde identificou sinais de choque hipovolêmico Classe III. Assinale a opção que apresenta os sinais desse tipo de choque.
A Hipotensão, FC oscilando entre 128 e 135bpm e perda sanguínea em torno de 1600 mL.

B FR = 25rpm, ansiedade leve e perda sanguínea em torno de 750ml.
C Perda sanguínea em torno de 1300 mL, enchimento capilar > 2seg e hipotensão.
D Letargia, FC = 142bpm, perda sanguínea acima de 2000 mL, e FR = 36rpm.
E Pressão de pulso diminuída, perda sanguínea em torno de 800mL e normotensão.

29. (IDECAN - SESAP - Técnico em Enfermagem - 2025) Diante de paciente politraumatizado com sangramento profuso e sinais de choque hipovolêmico, a priorização da assistência de enfermagem, segundo recomendações atualizadas, é:
A Manter acesso venoso calibroso e iniciar reposição rápida com volume cristaloide, postergando contenção hemorrágica até estabilização da pressão arterial.
B Aplicar compressão direta na fonte de hemorragia e monitorizar perfusão tecidual, utilizando-se de técnicas avançadas para prevenir exanguinação e agravos sistêmicos.
C Priorizar imobilização de extremidades fraturadas e solicitar exame radiológico completo antes de intervir no sangramento externo aparente.
D Realizar entubação orotraqueal de imediato, independentemente do estado respiratório, centralizando esforços exclusivamente na manutenção ventilatória.
E Administrar vasopressores para elevar rapidamente a pressão arterial, mesmo sem controle prévio do sangramento exanguinante.

30. (ADM&TEC - 2025 - Prefeitura de João Alfredo - Técnico de Enfermagem - Área: SAMU) Diante de uma vítima de acidente automobilístico com sinais de choque hipovolêmico por hemorragia externa ativa, qual a conduta inicial mais adequada?
A Controlar a hemorragia com compressão direta sobre o foco do sangramento e, se necessário, associar curativo compressivo e torniquete em lesões de extremidades, priorizando o controle da hemorragia antes da expansão volêmica.
B Aplicar torniquete proximal à lesão apenas se a hemorragia não cessar com curativo compressivo e elevação do membro, considerando sempre a necessidade de liberação periódica para evitar isquemia irreversível.
C Administrar solução cristalóide intravenosa em alta vazão para expandir o volume circulante e compensar a perda sanguínea, garantindo estabilidade hemodinâmica antes do controle da hemorragia.
D Posicionar a vítima em decúbito dorsal com os membros inferiores elevados (posição de *Trendelenburg*) para aumentar o retorno venoso e, em seguida, aplicar curativo compressivo sobre a área de sangramento.

31. (IBFC - 2025 - SES-SE - Enfermeiro - Urgência e Emergência) Ao atender paciente vítima de lesão por projéteis de arma de fogo em membro superior direito, observou-se sangramento arterial após compressão manual com gaze estéril. Assinale a alternativa que apresenta as condutas seguintes corretas.
A Retirar as gazes encharcadas e refazer a compressão com novas gazes estéreis
B Retirar as gazes encharcadas e refazer a compressão com novas gazes estéreis e utilizar torniquete pneumático
C Compressão circunferencial do membro distal à artéria
D Compressão circunferencial do membro proximal à artéria

32. (Aeronáutica - 2009 - EEAR - Sargento da Aeronáutica - Enfermagem) Sobre torniquete é correto afirmar
A Deve-se marcar com um lápis, num lugar visível do corpo, as letras TQ e a hora em que foi colocado.
B Deve ser o primeiro método utilizado em casos de hemorragia.
C Deve ser utilizado quando a vítima tiver o braço ou a perna fraturados.
D Ao ser confeccionado, deve-se utilizar preferencialmente arame ou barbante.

33. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Enfermeiro Emergencista) Sobre as possibilidades de atuação em emergências com traumas que produzem hemorragia, assinale a alternativa correta.

A A remoção precoce do torniquete é recomendada para evitar danos ao tecido, mesmo se a hemorragia persistir.

B A elevação do membro ferido é recomendada para reduzir a hemorragia em todos os casos, independentemente do tipo de lesão.

C O uso de hemostáticos tópicos pode ser considerado quando a pressão direta e o torniquete não são suficientes para controlar a hemorragia.

D A aplicação de um torniquete deve ser a primeira escolha para controlar hemorragias externas em todos os tipos de trauma.

E A pressão direta é ineficaz para controlar hemorragias arteriais e deve ser evitada.

34. (IDECAN 2024 - SES-PB - Enfermeiro Intensivista Pediátrico) O controle de hemorragias em pediatria em emergências exige intervenção precoce para prevenir choque hipovolêmico e morte. Em relação aos princípios no atendimento de hemorragias pediátricas em terapia intensiva, marque a alternativa correta.

A O volume sanguíneo total em crianças é significativamente maior do que em adultos, sendo que a perda de 20% do volume total em crianças geralmente não provoca choque hipovolêmico grave, o que permite abordagens menos agressivas inicialmente.

B A abordagem inicial em um quadro de hemorragia grave deve priorizar a monitorização invasiva do paciente e a coleta de exames laboratoriais, com estabilização clínica sendo iniciada apenas após a confirmação diagnóstica do tipo e extensão da hemorragia.

C A transfusão de hemoderivados em crianças com hemorragia grave deve seguir a proporção 1:1:1 (hemácias, plasma e plaquetas) para prevenir coagulopatia, sendo indicada em casos de hemorragia maciça.

D Em crianças com sangramento ativo e instabilidade hemodinâmica, a reposição volêmica com solução salina hipertônica (3%) deve ser a primeira escolha para estabilização inicial, em virtude de seu efeito expansor intravascular imediato, sendo indicada preferencialmente a outros cristaloides.

E O acesso venoso periférico em crianças com hemorragia deve ser tentado em até duas tentativas. Se não for bem-sucedido, deve-se considerar o uso de acesso intraósseo, especialmente em casos de instabilidade hemodinâmica, para administração rápida de fluidos e medicamentos de forma indiscriminada.

35. (IDECAN - 2025 - SESAP-RN - Cirurgião Dentista) Observe a seguinte situação:
Um paciente de 48 anos compareceu ao consultório odontológico para a extração dos elementos 46 e 47. No entanto, algumas horas após o procedimento, ele retornou relatando um sangramento persistente, que não cessava mesmo após compressão local com gaze. Diante dessa situação, o dentista optou por utilizar um agente tópico para auxiliar no controle da hemorragia. Nessa circunstância, é indicado o uso de ácido

A tranexâmico.

B acetilsalicílico.

C valproico.

D mefenâmico.

E tióctico.

36. (VUNESP - 2023 - EsFCEx - Oficial - Cirurgião Geral) O estudo CRASH-3 surgiu após as mudanças no Advanced Trauma Life Support (ATLS™), buscando responder à pergunta sobre os efeitos do ácido tranexâmico (TXA) nos pacientes com trauma cranioencefálico (TCE). A conclusão desse estudo foi:

A Houve aumento das complicações trombóticas com uso de TXA em pacientes politraumatizados.

B Houve diferença significativa na morte relacionada ao traumatismo craniano após 28 dias da ocorrência do trauma.

C O TXA é seguro em pacientes com TCE, e o tratamento em até 3 horas após a lesão reduz a morte relacionada a esse trauma.

D Não houve diminuição significativa da mortalidade de pacientes traumatizados com hemorragias graves.
E Não há indicação do uso de TXA no controle de sangramento na abordagem inicial ao trauma.

37. (IDECAN - 2024- SES-PB - Enfermeiro Emergencista) Sobre o tratamento geral do choque, assinale a alternativa correta.
A Tipicamente, administra-se estímulo hídrico; 100 ml (ou 20 mL/kg em crianças) de soro fisiológico a 0,5% é infundido ao longo de uma hora.
B O tratamento é iniciado simultaneamente à avaliação. Oxigênio suplementar é provido por meio de máscara facial. Em caso de choque grave ou ventilação inadequada, é necessária entubação endotraqueal com ventilação mecânica.
C Uma expansão com líquido deve ser administrada a paciente com sinais de edema pulmonar.
D Na hemorragia grave, usa-se comumente ringer com lactato, pois na hemorragia grave o uso de cristaloides deva ser maximizado em favor de transfusão de hemoderivados.
E Os primeiros socorros envolvem manter o paciente aquecido. A hemorragia externa é controlada, as vias respiratórias e a ventilação são verificadas; se necessário, suporte respiratório é administrado. Tudo é administrado por via oral, e a cabeça do paciente é virada para um dos lados, para evitar aspiração se ocorrer êmese.

38. (IDECAN 2024 - SES-PB - Enfermeiro Intensivista Pediátrico) No manejo do choque em pacientes pediátricos na UTI, o enfermeiro deve dominar as diferentes formas deste e suas abordagens terapêuticas. Conforme as diretrizes mais atuais, marque a opção correta sobre as condutas de enfermagem em casos de choque séptico, hipovolêmico, cardiogênico e distributivo em crianças.
A No choque hipovolêmico, a reposição volêmica com soluções cristaloides deve ser limitada a 10 mL/kg, administrada em bolus lento, para evitar sobrecarga hídrica, principalmente em pacientes com hipotensão arterial.
B A monitorização contínua da saturação venosa central de oxigênio (ScvO2) e o lactato sérico são parâmetros essenciais para guiar a terapia em choque séptico, devendo o enfermeiro intensivista avaliar também a diurese e o estado de perfusão periférica como parte da assistência multidisciplinar.
C O choque séptico deve ser inicialmente tratado com o uso de expansores plasmáticos, como albumina, ao invés de cristaloides, visando a uma maior eficácia na restauração da volemia e melhora da perfusão tecidual.
D Em casos de choque distributivo, o uso de vasodilatadores é uma estratégia eficaz na reversão da hipoperfusão tecidual, visto que esses fármacos aumentam o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, corrigindo a vasodilatação patológica.
E No choque cardiogênico, o uso de drogas vasoativas como noradrenalina e dopamina é recomendado após a estabilização hemodinâmica com reposição volêmica agressiva, com infusão de até 60 mL/kg em bolus rápidos.

39. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Enfermeiro Emergencista) O defeito fundamental no choque é perfusão reduzida dos tecidos vitais. Quando a perfusão declina e o fornecimento de oxigênio para as células é inadequado para o metabolismo aeróbico, as células alternam para o metabolismo anaeróbico, com maior produção de dióxido de carbono e níveis elevados de lactato no sangue. A função celular declina e, se o choque persiste, ocorrem lesões celulares irreversíveis e morte. Sobre o choque hipovolêmico, assinale a alternativa correta.
A A administração de fluidos intravenosos é contraindicada em casos de choque hipovolêmico devido ao risco de sobrecarga hídrica.
B A frequência cardíaca típica em um paciente com choque hipovolêmico é geralmente mais baixa devido à falta de volume sanguíneo.
C A principal causa de choque hipovolêmico é a falha cardíaca, resultando em insuficiência na bomba cardíaca.
D A reposição rápida de volume é um componente crítico do tratamento para choque hipovolêmico para restaurar a perfusão tecidual.

E A administração de vasopressores é a primeira linha de tratamento para choque hipovolêmico antes da reposição de volume.

40. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Enfermeiro Emergencista) Sobre as possibilidades de atuação em emergências com traumas que produzem hemorragia, assinale a alternativa correta.

A A remoção precoce do torniquete é recomendada para evitar danos ao tecido, mesmo se a hemorragia persistir.

B A elevação do membro ferido é recomendada para reduzir a hemorragia em todos os casos, independentemente do tipo de lesão.

C O uso de hemostáticos tópicos pode ser considerado quando a pressão direta e o torniquete não são suficientes para controlar a hemorragia.

D A aplicação de um torniquete deve ser a primeira escolha para controlar hemorragias externas em todos os tipos de trauma.

E A pressão direta é ineficaz para controlar hemorragias arteriais e deve ser evitada.

41. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Enfermeiro Emergencista) Sobre a avaliação inicial do paciente traumatizado, segundo o protocolo de atendimento em trauma, existe uma sequência de passos a serem realizados pela equipe de saúde. A respeito do primeiro passo a ser avaliado pela equipe de saúde, assinale a alternativa correta.

A Controle da hemorragia externa, que deve ser realizado antes da estabilização da coluna cervical, pois a hemorragia pode levar à morte rápida.

B Verificação da presença de pneumotórax, que deve ser a primeira ação em traumas torácicos, independentemente da condição da coluna cervical.

C Administração de fluidos intravenosos, que deve ser iniciada antes de qualquer avaliação física, para evitar choque hipovolêmico.

D Avaliação da circulação e pulso periférico, que deve ser feita imediatamente após a estabilização das vias aéreas, para garantir a perfusão adequada.

E Estabilização da coluna cervical, que é fundamental para prevenir lesões adicionais e deve ser a primeira ação em todos os casos de trauma.

42. (FGV - 2021 - FUNSAÚDE - CE - Médico – Cirurgia Geral) Sobre o *choque hemorrágico*, assinale a afirmativa correta.

A No choque classe II, há aumento da frequência cardíaca, sem queda nas pressões de pulso e arterial;

B A acidose metabólica grave dos estados de choque persistente é tratada com reposição de fluidos, sangue e bicarbonato de sódio;

C A reposição volêmica no trauma abdominal penetrante pode ser menos agressiva, permitindo estados de hipotensão controlada;

D O débito urinário é um indicador menos sensível de resposta à reposição volêmica do que a frequência cardíaca e a pressão arterial sistêmica;

E No choque grau III há necessidade de hemotransfusão, que é prioritária em relação ao controle da hemorragia.

43. (FUNDATEC - 2022 - Prefeitura de Flores da Cunha - RS - Técnico em Enfermagem) O choque neurogênico consiste na perda do tônus simpático devido à denervação decorrente, por exemplo, de trauma raquimedular. São sinais clínicos de choque neurogênico, EXCETO:

A Hipotensão.

B Taquicardia.

C Pele seca e quente.

D Bradicardia.

E Pele hiperemiada.

44. (IDECAN - 2017 - INCA - Medicina Emergencista) O pneumotórax é uma condição comum na prática clínica e pode estar relacionado a diversos mecanismos como trauma, doenças de base e até mesmo ter caráter idiopático. Sobre o pneumotórax hipertensivo, é correto afirmar que:

A É decorrente de um trauma torácico fechado.

B O que caracteriza um pneumotórax como hipertensivo é a presença de desvio acentuado do

mediastino com estabilidade hemodinâmica do paciente.
C No pneumotórax hipertensivo não se observa o achado clínico típico de desvio contralateral da traqueia; contudo, há diminuição do murmúrio vesicular no hemitórax acometido.
D A causa mais comum, de acordo com o ATLS, é a ventilação com pressão positiva em pacientes com lesões pleurais e/ou pulmonares prévias, mas que passaram despercebidas durante o primeiro exame.

45. (IDECAN - 2014 - EBSERH - Médico - Cirurgia Geral) Quando se avalia um indivíduo politraumatizado é necessário tratamento imediato, com uma rápida avaliação das lesões e aplicação de medidas terapêuticas de suporte de vida. Acerca da avaliação e atendimento do politraumatizado com pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto e tórax instável, assinale a alternativa correta.
A Na suspeita de pneumotórax hipertensivo, deve-se aguardar o diagnóstico radiológico para a instituição terapêutica.
B No tórax instável, durante a inspiração, o segmento fraturado se abaula e, durante a expiração, o segmento fraturado se colaba.
C No pneumotórax aberto, o tratamento imediato é a oclusão completa da ferida com curativo quadrangular, fixado nos 4 lados.
D O pneumotórax hipertensivo é mais frequentemente encontrado nos traumatismos torácicos fechados do que nos penetrantes.
E A punção feita em casos de pneumotórax hipertensivo deve ser feita idealmente com agulha grossa, no quarto espaço intercostal, na linha axilar anterior.

46. (IDECAN - 2024 - Prefeitura de Mossoró - RN - Fisioterapeuta) Após um acidente automobilístico, uma pessoa foi encaminhada ao Pronto Socorro. Durante exame físico, apresentaram-se murmúrio vesicular diminuído em hemitórax esquerdo e percussão timpânica. Na radiografia do tórax, verificaram-se a presença de parênquima pulmonar direito contraído, a ausência de trama vascular em hemitórax direito e o desvio do mediastino para o lado contralateral. De acordo com os sinais clínicos e radiológicos, assinale a alternativa que indica o diagnóstico do paciente.
A Fibrotoráx.
B Enfisema pulmonar.
C Derrame pleural.
D Pneumotórax.
E Atelectasia.

47. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente) Sobre o pneumotórax, assinale a alternativa INCORRETA.
A É caracterizado pela presença de ar na cavidade pleural.
B O seu tratamento é a toracotomia independente do tamanho do pneumotórax, intensidade dos sintomas e
repercussão clínica.
C O pneumotórax hipertensivo leva à compressão das estruturas mediastinais, diminuindo o retorno venoso e
comprimindo as câmaras venosas cardíacas.
D As principais consequências fisiológicas dependem da magnitude do pneumotórax, da condição do pulmão
subjacente e do nível tensional, que ocasionam restrição à ventilação pulmonar.

48. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente ANULADA) Sobre o tórax instável, é INCORRETO afirmar que
A é definido como a fratura do esterno.
B quando presente, há perda da estabilidade da parede torácica.
C à palpação do tórax nota-se crepitação dos arcos costais à respiração.
D pode ser observada a presença de movimento paradoxal da parede torácica à inspeção.

49. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente ANULADA) O pneumotórax hipertensivo é uma situação que coloca o indivíduo com risco iminente de vida, sendo classificado de elevada gravidade, podendo provocar colapso circulatório devido à(ao):
A Desvio do mediastino.

B Diminuição da pressão intratorácica.
C Diminuição da volemia.
D Redução da expansão torácica do lado acometido

50. (IDECAN - 2017 - INCA - Médico Emergencista) "Homem, 45 anos, vítima de acidente por arma branca em região de hemitórax direito, chega ao pronto-socorro com sinais vitais estáveis e presença de desconforto respiratório. Foram realizadas drenagem torácica com vazamento de ar pela cavidade e intubação orotraqueal eletiva. Depois de iniciada a ventilação mecânica com pressão positiva, o paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória." O que levou o paciente a este quadro?
A Embolia gasosa.
B Aneurisma de coronária.
C Tamponamento cardíaco.
D Suboclusão prévia de artéria carótida.

51. (IDECAN - 2014 - EBSERH - Médico - Cirurgia Vascular → Correlata com a Anterior) Todo paciente com embolia pulmonar aguda deve ser rapidamente estratificado em relação ao risco de evolução adversa. Pacientes com sinais de instabilidade hemodinâmica devem ser avaliados para trombólise sem demora, sob o risco de instalação de choque cardiogênico irreversível. Pacientes classificados como alto risco, com sinais de aumento moderado ou grave de ventrículo direito, porém, sem hipotensão e baixo risco de sangramento, também devem ser avaliados para trombólise. São contraindicações absolutas para a trombólise, EXCETO:
A Gestação.
B Trauma ou cirurgia recente de grande porte.
C Lesão ou neoplasia do sistema nervoso central.
D Acidente vascular encefálico isquêmico nos últimos 6 meses.
E Acidente vascular hemorrágico ou de etiologia indeterminada em qualquer tempo.

52. (IDECAN - 2014 - CNEN - Enfermeiro) Cansaço, falta de ar, edema de membros inferiores, hepatomegalia, ascite, palpitação, palidez cutânea, sudorese fria, fadiga, fraqueza e dispneia paroxística noturna, são sinais e sintomas da seguinte doença:
A Asma.
B Angina.
C Pneumonia.
D Trombose venosa profunda.
E Insuficiência cardíaca congestiva.

53. (IDECAN - UFSB - Enfermeiro - 2025) Durante a assistência de enfermagem a um paciente com insuficiência cardíaca descompensada, é essencial implementar intervenções baseadas em evidências que favoreçam a perfusão tecidual e reduzam a sobrecarga hemodinâmica. Marque a opção que representa uma conduta apropriada nessa situação.
A Aplicar calor local nos membros inferiores para estimular a vasodilatação periférica, mesmo na presença de edema significativo.
B Monitorar o balanço hídrico a cada 24 horas, priorizando o uso de diuréticos de longa duração sem ajuste para função renal.
C Incentivar a elevação do decúbito a 90°, mesmo na presença de ortopneia, com o objetivo de facilitar a drenagem venosa.
D Avaliar turgor cutâneo como indicador primário de perfusão periférica, desconsiderando débito urinário e enchimento capilar.
E Posicionar o paciente em semi-fowler, administrar oxigenoterapia conforme prescrição e monitorar sinais de hipoperfusão sistêmica.

54. (FGV - 2023 - FHEMIG - Enfermeiro) Durante o exame físico de um paciente adulto, sexo masculino, o Enfermeiro identificou sinais característicos da *Tríade de Beck.*
Assinale a opção que os apresenta.
A Bradicardia, hipertensão arterial e bradipneia.
B Febre com calafrios, dor abdominal e icterícia.
C Estase de jugular, hipofonose de bulhas e hipotensão.
D Hipercoagulabilidade, estase venosa e lesão endotelial.
E Coagulopatia, hipotermia e acidose metabólica.

55. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Enfermeiro Emergencista) O Edema Agudo de Pulmão (EAP) é uma síndrome clínica de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica decorrente de etiologias variadas. Neste cenário, decisões terapêuticas rápidas são essenciais, mesmo que com informações limitadas. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

A A pressão arterial pode estar baixa, normal ou elevada. Quando baixa, sugere o EAP hipotensivo e quando alta, o EAP secundário a choque cardiogênico.

B No EAP cardiogênico, o desacoplamento entre o volume sistólico do ventrículo direito e esquerdo e a venoconstrição hipóxica contribuem para um aumento da pressão hidrostática nos capilares pulmonares. O resultado é a transudação de líquido para o interstício pulmonar, causando dispneia intensa e abrupta, tosse com expectoração abundante hialina-hemoptóica, taquipnéia, cianose e extremidades frias e sudoréticas.

C Na maioria dos casos, o EAP tem múltiplas causas, por exemplo, um paciente com choque séptico e síndrome de angústia respiratória aguda (SARA) pode apresentar sobrecarga volêmica devido à ressuscitação agressiva com cristalóides, cursando com EAP misto.

D No EAP cardiogênico, ocorrem inflamação e aumento da permeabilidade capilar com exudação de líquido para interstício pulmonar. O exame físico não costuma revelar as alterações cardíacas descritas acima.

56. (UFMT - Prefeitura de Campos de Júlio - Enfermeiro - 2024) Em relação à assistência de enfermagem ao paciente politraumatizado em ambiente pré-hospitalar, segundo o protocolo do PHTLS, analise as afirmativas.

I. Choque é definido como a ausência de perfusão tecidual (oxigenação) em nível celular, levando ao metabolismo anaeróbico e à perda da produção de energia necessária à vida.

II. O choque pode ser classificado como hipovolêmico, distributivo ou cardiogênico, se forem considerados os seguintes componentes do sistema de perfusão: o coração, o volume de líquidos, os vasos sanguíneos e as células corporais.

III. Dentre as manifestações do choque estão a hipotensão arterial, a taquicardia, a pele fria e úmida, a hipóxia, a tríade de back e midríase.

IV. Pacientes considerados como grandes queimados devem ser avaliados pelo método da "Regra dos Dez" para determinação da quantidade da reposição volêmica na prevenção de choque.

V. A sequência mnemônica do XABCDE, segundo o PHTLS, sugere o tratamento do choque no A, que significa "Abertura das vias aéreas e controle de hemorragias com reposição volêmica".

Está correto o que se afirma em

A I, II e III, apenas.

B I e II, apenas.

C III, IV e V, apenas.

D IV e V, apenas.

57. (IDECAN - 2014 - EBSERH - Médico - Cirurgião Geral) O choque é uma síndrome caracterizada por insuficiência circulatória aguda com má distribuição generalizada do fluxo sanguíneo, que implica falência de oferta e/ou utilização do oxigênio nos tecidos. Sobre o choque, assinale a afirmativa INCORRETA.

A O choque hipovolêmico é a forma mais comum de choque.

B No choque anafilático, a droga de escolha é a noradrenalina.

C O infarto agudo do miocárdio é a causa mais comum de choque cardiogênico.

D A IL-6 é o melhor preditor de recuperação prolongada e desenvolvimento de falência de múltiplos órgãos após o choque.

E Quando o paciente encontra-se em sepse grave e hipotensão, e esta não se reverte com a infusão de líquidos, o diagnóstico é de choque séptico.

58. (IDECAN - 2017 - INCA - Médico Emergencista) Em pacientes vítimas de traumas contusos, muitas vezes, é necessária a realização de exames complementares como

o Lavado Peritoneal Diagnóstico ou a Ultrassonografia de Abdômen (FAST) para sua elucidação diagnóstica. Estes exames complementares, na urgência, NÃO são indicados no seguinte caso:

A Paciente em choque neurogênico.

B Hipotensão ou choque sem causa aparente no politraumatizado.

C Paciente com uma possível hemorragia abdominal como os pacientes com fratura pélvica.

D Pacientes com contusão abdominal em que o exame físico não é elucidativo devido ao rebaixamento do nível de consciência.

59. (IDECAN - 2014 - EBSERH - Médico - Cirurgia Geral) Em um indivíduo politraumatizado, após a garantia de ventilação adequada, procede-se a avaliação hemodinâmica. Sobre esta avaliação, marque a alternativa INCORRETA.

A O tratamento emergencial do tamponamento cardíaco agudo é a toracotomia.

B A infusão de grandes volumes de soro fisiológico pode levar à acidose hiperclorêmica.

C No tamponamento cardíaco, a reposição volêmica pode melhorar de forma transitória os parâmetros hemodinâmicos.

D A embolia aérea é uma complicação comum do trauma pulmonar, e apenas uma pequena parcela dos acometidos evolui a óbito.

E Em crianças menores de 6 anos com acessos periféricos difíceis, a agulha intraóssea deve ser tentada antes da obtenção de acesso central.

60. (IDECAN - 2014 - EBSERH - Médico - Medicina Intensiva) A dissecção aguda da aorta é causada por uma delaminação súbita da camada íntima, com formação de falsa luz que pode destruir a camada média e ter extensão variável, ou ainda, uma hemorragia da média com ruptura da íntima e propagação da dissecção através desta. A propagação da dissecção, responsável por muitos dos sintomas associados, pode ser proximal ou distal ao ponto de delaminação, podendo haver várias comunicações entre a verdadeira e a falsa luz (sítios de reentrada). Em cerca de 70% dos pacientes, as dissecções aórticas se localizam na aorta ascendente a alguns centímetros da valva aórtica. Assinale, a seguir, o(s) sintoma(s) principal(is) que caracteriza(m) a DAA.

A Náuseas, vômitos, suor frio e bradicardia, sendo necessária a ventilação precoce.

B A dor torácica, ocorrendo de forma lenta e progressiva, principalmente na face posterior do tórax, sendo normalmente sem irradiações.

C Sintomas neurológicos como a perda de consciência, paresia e parestesia de membros superiores se referem ao sintoma inicial da DAA.

D Junto com a elevação da PA, os principais sintomas da DAA são a cefaleia intensa e a dor retro-ocular que caracterizam a patologia dessa doença.

E A dor torácica, ocorrendo de forma súbita e intensa, principalmente na face anterior do tórax, podendo ainda ser dorsal (interescapular) ou migratória, irradiando para ombros, pescoço e abdômen conforme sua progressão.

61. (IDECAN - PB - Enfermeiro - 2024) Em relação às emergências relacionadas às doenças do aparelho respiratório, assinale a alternativa correta.

A A ventilação mecânica invasiva deve ser evitada em todos os casos de insuficiência respiratória aguda para prevenir complicações.

B A intubação endotraqueal é contraindicada em qualquer situação de emergências respiratórias, independentemente da gravidade.

C Em casos de asma aguda, a administração de medicamentos broncodilatadores é desnecessária se o paciente tiver histórico de tratamento.

D Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) não devem receber oxigênio suplementar em crises agudas.

E O tratamento da pneumonia severa inclui o uso de antibióticos apropriados e, em alguns casos, suporte ventilatório.

62. (IDECAN - PB - Enfermeiro - Área Hemoterapia - 2024) J.S.P., 29 anos, sexo masculino foi vítima de uma colisão entre carros e recebeu atendimento inicial pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU.

Durante a avaliação, constatou-se um quadro de hemorragia aguda em membro inferior direito. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, com base nos sinais e sintomas, assinale em qual das seguintes situações seria indicada transfusão de a concentrado de hemácias para J.S.P.

A Taquicardia, Hipotensão arterial, Taquipneia e Enchimento capilar retardado (> 2 segundos).

B Bradicardia, Hipotensão arterial, Taquipneia e Poliúria.

C Bradicardia, Hipotensão arterial, Taquipneia e Enchimento capilar retardado (> 2 segundos).

D Taquicardia, Hipertensão arterial, Bradipneia e Poliúria.

E Taquicardia, Taquipneia, Enchimento capilar rápido <(2 segundos) e Hematúria.

63. (IDECAN - SESAP - Cirurgião Dentista - Área: Odontologia Hospitalar - 2025) Emergência hipertensiva e Urgência hipertensiva são crises de hipertensão arterial com diagnósticos diferentes. Assinale a alternativa que indica a PA que caracteriza uma emergência hipertensiva.

A Acima de 220/140 mmHg.

B Acima de 180/110 mmHg.

C Acima de 160/90 mmHg.

D Acima de 140/90 mmHg.

E Acima de 130/110 mmHg.

64. (OBJETIVA - 2022 - Prefeitura de Arroio do Padre - RS - Enfermeiro) A emergência hipertensiva é uma situação em que a pressão arterial está extremamente elevada (acima de 180/120 mmHg) e deve ser reduzida imediatamente, mas não necessariamente para menos de 140/90 mmHg, a fim de interromper ou evitar a lesão dos órgãos-alvo. Essas emergências hipertensivas são elevações da pressão arterial aguda e são potencialmente fatais, que exigem tratamento imediato em um ambiente de terapia intensiva, devido à grave lesão que pode ocorrer nos órgãos-alvo. A avaliação revela a disfunção clínica atual ou em desenvolvimento do órgão-alvo. As condições associadas a uma emergência hipertensiva incluem:

A Hipertensão na gravidez, infarto agudo do miocárdio, aneurisma dissecante da aorta e hemorragia intracraniana.

B Hipertensão secundária, angina pectoris e isquemia cerebral.

C Hipertensão resistente, aneurisma cerebral e hemorragia intracraniana.

D Hipertensão primária, angina instável e infarto agudo do miocárdio.

65. (FGV - 2023 - FHEMIG - Médico - Clínica Médica) Sobre *urgência hipertensiva* e *emergência hipertensiva*, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Urgência hipertensiva caracteriza-se por uma elevação acentuada da pressão arterial, com lesão progressiva de órgão alvo, com maior risco de óbito.

( ) Emergência hipertensiva caracteriza-se por uma elevação pressórica acentuada, sem lesão aguda e progressiva de órgão alvo.

( ) Eclampsia e síndrome HELLP são exemplos de urgências hipertensivas.

( ) Pré-eclampsia e hipertensão associada a aneurisma de aorta não dissecante são exemplos de emergências hipertensivas.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

A F – V – F – V.

B F – F – F – F.

C V – F – V – V.

D V – V – V – V.

E V – F – V – F.

66. (FUNDEP - 2019 - HRTN - MG - Médico Plantonista - Terapia Intensiva) Com relação às emergências hipertensivas, assinale a alternativa incorreta.

A A crise hipertensiva é a entidade clínica em que há aumento súbito, aleatoriamente definida como pressão arterial ≥ 180/110 mmHg, e sintomático da pressão arterial.

B Na urgência hipertensiva, o aumento crítico da pressão arterial não apresenta risco imediato de morte e nem lesão aguda em órgãos-alvo.

C A emergência hipertensiva é a situação clínica caracterizada por níveis muito elevados de

pressão arterial e sinais de lesões progressivas em órgãos-alvo.
D Nas urgências hipertensivas, a pressão arterial deverá ser reduzida em alguns minutos até uma hora e, nas emergências, em tempo mais prolongado, de 2 a 24 horas, de forma progressiva.

67. (IDECAN - Prefeitura de Mossoró - Técnico em Enfermagem - 2024) A síndrome *HELLP* é o achado extremo do espectro de alterações que ocorrem na hipertensão induzida pela gestação/ pré-eclâmpsia 7 e como seus sinais e sintomas são confundidos com os da pré-eclâmpsia grave, as formas leves podem passar desapercebidas. Sobre a síndrome mencionada, a principal complicação durante a gravidez, corresponde a
A complicações gastrointestinais.
B insuficiência renal.
C problemas respiratórios.
D distúrbios hematológicos.
E anomalias cardíacas no feto.

68. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente Reaplicação) Alguns pacientes, principalmente aqueles com doença da artéria coronária, podem desenvolver isquemia miocárdica quando a frequência cardíaca é aumentada. A explicação correta para este fato é que o aumento da frequência cardíaca:
A Encurta o tempo da sístole atrial, diminuindo a perfusão miocárdica.
B Encurta o tempo da diástole ventricular, diminuindo a perfusão miocárdica.
C Compromete as trocas gasosas sanguíneas, diminuindo a oxigenação miocárdica.
D Diminui o débito cardíaco, aumentando as necessidades metabólicas do miocárdio.

69. (IDECAN - 2024 - CBM-MG - Oficial - Cadete) Um paciente de 45 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica não controlada, apresenta-se com dor torácica típica de angina estável há dois meses. Os exames laboratoriais revelam dislipidemia mista e glicemia de jejum alterada. O eletrocardiograma evidencia sobrecarga ventricular esquerda. Indique a alternativa que corresponde à principal alteração fisiopatológica responsável pelos sintomas desse paciente.
A Espasmo coronariano.
B Aterosclerose coronariana.
C Hipertrofia ventricular esquerda.
D Disfunção diastólica.

69. (IDECAN - CBM MG - Enfermeiro - Área: Emergencista - 2024) Infarto agudo do miocárdio é a necrose miocárdica resultante de obstrução aguda de uma artéria coronária. Os sintomas incluem desconforto torácico com ou sem dispneia, náuseas e/ou diaforese. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.
A A dor/desconforto deve ser caracterizada quanto a três informações fundamentais: primeiro a característica, retroesternal ou precordial; mal localizada, podendo se apresentar em aperto, peso ou pressão, e algumas vezes queimação; e que pode irradiar, para pescoço e membros inferiores.
B Ainda, é preciso atentar-se às características que aumentam a probabilidade de se tratar de SCA. São elas: dor pleurítica — ventilatório dependente; dor cortante ou em pontada; dor posicional; dor não associada a esforço físico; dor reprodutível à palpação e dor com duração de segundos.
C Ainda hoje, só se usa para fins de classificação da dor de acordo com sua caracterização: em dor do tipo A, definitivamente anginosa; do tipo B, provavelmente anginosa; do tipo C, provavelmente não anginosa; e do tipo D, definitivamente não anginosa. Não há outra nomenclatura.
D Para fins de emergência, considera-se como dor torácica qualquer dor localizada entre a mandíbula e o epigástrio. É importante ressaltar, no entanto, que o termo "dor" é impreciso, e que, muitas vezes, o paciente vai descrever apenas um desconforto.

70. (IBFC - 2022 - EBSERH - Médico - Cirurgia Cardiovascular) É sabido que o infarto agudo do miocárdio leva à necrose miocárdica resultante de obstrução aguda de uma artéria coronária. Os sintomas incluem desconforto

torácico com ou sem dispneia, náuseas e diaforese. Após o infarto agudo do miocárdio, pode-se encontrar terríveis complicações. Sobre elas, assinale a alternativa incorreta.

A Comunicação interventricular
B Insuficiência mitral aguda
C Ruptura cardíaca
D Aneurisma ventricular
E Insuficiência aórtica

71. (IDECAN - 2022 - PC-BA - Perito Médico Legista de Polícia Civil) Doenças isquêmicas do coração ainda são a primeira causa de morte no Brasil. Sobre patologias cardíacas, escolha a alternativa verdadeira.

A Para se reduzir o risco cardiovascular aterosclerótico, deve-se iniciar estatina quando o a fração LDL do colesterol estiver acima de 180mg/dL, mesmo sem outros riscos associados.
B Em pacientes com angina há sempre alteração do ECG.
C Em caso de Infarto Agudo do Miocárdio com elevação de ST, a terapia fibrinolítica em até 30 minutos da entrada no hospital deve ser implementada e reduz mortalidade se iniciada em até 12 horas de início dos sintomas.
D Taquicardia paroxística supraventricular raramente responde a manobras vagais, bloqueadores do nó AV ou adenosina.
E Em caso de morte súbita em paciente com menos de 35 anos, doença coronariana deve ser investigada primordialmente.

72. (IDECAN - 2017 - CBM-DF - 2º Tenente - Médico Cardiologia) Dentre as classes de medicações utilizadas no tratamento das síndromes coronarianas agudas, assinale a que deve ser evitada, caso haja suspeita de comprometimento do ventrículo direito.

A AAS.
B Nitrato.
C Clopidogrel.
D Henoxaparina.

73. (IDECAN - 2014 - EBSERH - Médico - Cardiologia) As doenças cardiovasculares causam um terço (16,6 milhões em 2001) de todas as mortes no mundo e a doença arterial coronariana (DAC) é a causa de 7,2 milhões dessas mortes. Sobre a perfusão e a doença isquêmica do miocárdio, é INCORRETO afirmar que

A a isquemia miocárdica leva ao atraso no relaxamento cardíaco.
B a angina instável equivale à isquemia miocárdica estresse-induzida.
C o consumo miocárdico de oxigênio é dependente da frequência cardíaca, da contratilidade miocárdica e da pós-carga.
D durante a sístole, tem-se maior débito sanguíneo das veias coronárias, devido à compressão da microvasculatura do miocáridio quando o coração contrai.
E hipertensão arterial, Diabetes *mellitus*, dislipidemia e tabagismo levam à deposição de substâncias aterogênicas no endotélio, inativando o óxido nítrico.

74. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Enfermeiro Emergencista) As queimaduras são lesões decorrentes de agentes (tais como a energia térmica, química ou elétrica) capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. Tais agravos podem ser classificados como queimaduras de primeiro grau, de segundo grau ou de terceiro grau. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

A Para superfícies corporais de pouca extensão ou que atinjam apenas partes dos segmentos corporais, utiliza-se, para o cálculo da área queimada, o tamanho da palma da mão (incluindo os dedos) do paciente, o que é tido como o equivalente a 5% da SCQ.
B O processo de reparação tecidual do queimado dependerá de vários fatores, entre eles a extensão local e a profundidade da lesão. Por sorte, a queimadura não afeta o sistema imunológico da vítima, não tendo, portanto, repercussões sistêmicas importantes, com consequências sobre o quadro clínico geral do paciente.
C Para o cálculo da extensão do agravo, normalmente utiliza-se a conhecida regra dos nove, criada por Wallace e Pulaski, que leva em conta a extensão atingida, a chamada Superfície Corporal Queimada (SCQ).

D O cálculo da extensão do agravo é classificado de acordo com a altura da pessoa.

75. (IDECAN - 2023 - SSP-SE - Papiloscopista) Em relação às lesões causadas pela ação da temperatura, assinale a alternativa incorreta.
A A presença de flictenas caracteriza uma queimadura de terceiro grau.
B As queimaduras são provocadas por ação direta do calor.
C As queimaduras podem resultar do contato de parte do corpo com chamas, sólidos e gases aquecidos, líquidos escaldantes e raios solares.
D As queimaduras podem ser classificadas, conforme a profundidade ou a área corporal atingida, sendo usualmente aplicada a Regra dos Nove de Pulaski e Tennisson.
E A lesão causada pela ação localizada do frio, apresenta as mesmas características das queimaduras, entretanto, a denominação correta é geladura.

76. (IDECAN - 2021 - PEFOCE - Odontologia) As queimaduras ocorrem por contato direto do calor com o corpo, por meio de chama, de sólido, de gás ou de líquidos quentes. Quanto à classificação, de acordo com Hoffmann e Lussena, há queimaduras de quatro graus distintos. Relacione os graus de queimaduras com suas respectivas particularidades.
1. Primeiro grau
2. Segundo grau
3. Terceiro grau
4. Quarto grau
( ) Observa-se combustão dos tecidos mais profundos. O calor produz a calcinação dos ossos, que se transformam em um material branco-acinzentado, bastante friável.
( ) Hiperemia dos capilares superficiais, com vermelhidão da pele. A recuperação é total, depois de um período variável de descamação epidérmica.
( ) Ocorre quando a temperatura atinge os 180ºC. A área necrótica exibe uma consistência firme e maior que a dos tecidos vizinhos não queimados, discretamente deprimida, de cor castanha.
( ) Formações cheias de líquido seroso, que levantam o estrato córneo da epiderme, podendo variar em número e volume. Assinale a alternativa que apresente a sequência correta, de cima para baixo.
A 3 – 2 – 4 – 1.
B 4 – 1 – 3 – 2.
C 4 – 2 – 3 – 1.
D 4 – 3 – 2 – 1.
E 3 – 4 – 2 – 1.

77. (IDECAN - 2014 - EBSERH - Médico - Cirurgia Torácica) São múltiplos os fatores envolvidos nas queimaduras que devem ser observados. Algumas situações, quando presentes, fazem com o que o paciente seja considerado grande queimado ou queimado de grande gravidade, independente da extensão da queimadura. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma dessas situações.
A Politrauma.
B Lesão inalatória associada.
C Choque de qualquer origem.
D Fratura óssea em qualquer localização.
E Queimadura causada por eletricidade, exceto em crianças.

78. (IDECAN - 2017 - CBM-DF - 2º Tenente - Médico Medicina do Trabalho) São considerados acidentes de trabalho graves, EXCETO:
A Acidente ocular.
B Queimadura de 3º grau.
C Acidente envolvendo menor de 18 anos.
D Acidente envolvendo trabalhador informal.

79. (IDECAN - 2014 - EBSERH - Médico - Cirurgia Plástica) Sobre a classificação das queimaduras, analise. I. Queimaduras de primeiro grau atingem a epiderme e a parte superficial da derme, causando eritema. **II.** Queimaduras de segundo grau apresentam como sinais clínicos característicos eritema e bolhas. **III.**

Queimaduras de terceiro grau envolvem a epiderme e a derme, podendo se apresentar lesão branca nacarada. **Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)**
A I, II e III.
B I, apenas.
C I e II, apenas.
D I e III, apenas.
E II e III, apenas.

80. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Soldado Operacional) As queimaduras podem ser classificadas de acordo com a profundidade, a saber: queimaduras de primeiro grau; de segundo grau (superficial e profunda); e, de terceiro grau. O sinal mais característico da queimadura de segundo grau é:
A Presença de eritema.
B Aparecimento de flictena.
C Presença de placa enegrecida.
D Presença de placa esbranquiçada.

81. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Soldado Operacional) Na avaliação de uma queimadura é importante, para determinar a sua gravidade, considerar fatores como a extensão, a profundidade, a localização, a etiologia, a hora zero, entre outros. Para calcular a extensão ou a porcentagem da Superfície Corporal Total Queimada (SCTQ) existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas. Uma delas é tomar como referência a palma da mão do paciente com os dedos estendidos e juntos que representa, aproximadamente:
A 1% da SCTQ.
B 2% da SCTQ.
C 3% da SCTQ.
D 5% da SCTQ.

82. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente) Entre os órgãos atingidos pelas queimaduras, a pele é a mais frequentemente afetada. Considerada o maior órgão do corpo humano, a pele é a parte do organismo que recobre e resguarda a superfície corporal, tendo algumas funções, tais como controlar a perda de água e proteger o corpo contra atritos. Um jovem de 25 anos, que sofreu queimaduras no membro superior esquerdo anteriormente, membro superior direito por completo, tórax e abdômen anteriormente e genitália, apresentará qual percentual de área corporal queimada?
A 19,5%.
B 28%.
C 32,5%.
D 37%.

83. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente) Quanto à profundidade da queimadura, relacione adequadamente as colunas a seguir.
1. Primeiro grau. **2.** Segundo grau. **3.** Terceiro grau.
( ) Afeta somente a epiderme, sem formar bolhas. Apresenta vermelhidão, dor, edema e descama em 4 a 6 dias.
( ) Afeta a epiderme, a derme e estruturas profundas. É indolor. Existe a presença de placa esbranquiçada ou enegrecida. Possui textura coreácea. Não reepiteliza e necessita de enxertia de pele.
( ) Afeta a epiderme e parte da derme, forma bolhas ou flictenas. Superficial: a base da bolha é rósea, úmida e dolorosa. Profunda: a base da bolha é branca, seca, indolor e menos dolorosa (profunda). A restauração das lesões ocorre entre 7 e 21 dias.
A sequência está correta em
A 1, 3, 2.
B 1, 2, 3.
C 2, 3, 1.
D 3, 1, 2.

84. (IDECAN - 2017 - CBM-DF - Aspirante do Corpo de Bombeiro) Entre os órgãos atingidos pelas queimaduras, a pele é a mais frequentemente afetada. Considerada o maior órgão do corpo humano, a pele é a parte do organismo que recobre e resguarda a superfície corporal, tendo algumas funções, tais como controlar a perda de água e proteger o corpo contra atritos. Um jovem de 25 anos,

que sofreu queimaduras no membro superior esquerdo anteriormente, membro superior direito por completo, tórax e abdômen anteriormente e genitália, apresentará qual percentual de área corporal queimada?
A 19,5%.
B 28%.
C 32,5%.
D 37%.

85. (IDECAN - FMS - Assistente de Saúde - Área: Técnico de Enfermagem - 2024) Paciente adulto, 30 anos, deu entrada no pronto-socorro após ter sofrido queimaduras de segundo e terceiro graus em membros superiores e inferior total esquerdo. Segundo a regra dos nove, assinale a alternativa que indica a porcentagem da extensão da queimadura.
A 45%.
B 9%.
C 27%.
D 36%.
E 18%.

86. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Enfermeiro Obstetra/Obstetriz) Paciente, 30 anos, chega na unidade de pronto atendimento apresentando queimaduras na região de hemitórax esquerdo, um lado do antebraço esquerdo, órgão genital e perna esquerda. De acordo com a regra dos nove, estima-se que a superfície corporal queimada foi de
A 23,5%.
B 28%.
C 32,5%.
D 32%.
E 25,75%.

87. (IDECAN - 2014 - CNEN - Enfermeiro) "Paciente adulto, 50 anos, deu entrada no pronto-socorro após ter sofrido queimaduras elétricas de segundo e terceiro graus em membros superior e inferior total esquerdo e genitália." Segundo a regra dos nove, qual a porcentagem da extensão da queimadura?
A 9%.
B 13,5%.
C 18%.
D 28%.
E 30%.

88. (IDECAN - 2014 - EBSERH - Médico - Cirurgia Plástica) Queimaduras são lesões dos tecidos orgânicos em decorrência de trauma de origem térmica resultante da exposição ou contato com chamas, líquidos quentes, superfícies quentes, eletricidade, frio, substâncias químicas, radiação, atrito ou fricção. Segundo a Regra dos Nove, na avaliação no pronto-atendimento, a superfície corporal queimada em um adulto com acometimento da cabeça, pescoço e tronco posterior, é de
A 18%.
B 27%.
C 36%.
D 45%.
E 54%.

89. (IDECAN - CFA - 2013) Em relação às queimaduras de face e pescoço, é INCORRETO afirmar que a(s)
A queimaduras radiantes são provocadas por exposição ao: sol, raio-x e raio gama.
B queimaduras podem ser causadas por agentes: térmicos, químicos, elétricos ou radioativos.
C queimaduras podem ser classificadas quanto a: etiologia, profundidade, extensão e período evolutivo.
D fase de proliferação aguda do processo de cicatrização inicia-se em 6 a 8 dias e conclui-se em 8 a 12 meses.
E infecção pode impedir, nas queimaduras parciais, sua cura rápida, pela destruição dos anexos, levando à ulceração e cicatrização de segunda intenção.

90. (IDECAN - 2014 - EBSERH - Biomédico) A concentração das proteínas plasmáticas é determinada por três fatores principais: velocidade de síntese, velocidade do catabolismo e volume de líquido, no qual as proteínas estão distribuídas. Alterações nas concentrações das proteínas plasmáticas podem levar a distúrbios importantes, como

hipoproteinemia ou hiperproteinemia. São consideradas causas de hipoproteinemia, EXCETO:
A Pode ocorrer quando há diminuição do volume plasmático.
B Pode ocorrer na síndrome nefrótica e glomerulonefrite crônica.
C Ocorre em casos de desnutrição ou dietas pobres em proteínas.
D Indivíduos com queimaduras severas podem sofrer de hipoproteinemia devido à perda de proteínas pela pele.
E Enfermidades hepáticas crônicas diminuem a síntese proteica pelos hepatócitos e podem levar a um quadro de hipoproteinemia.

91. (IDECAN - 2014 - EBSERH - Médico - Cirurgia Plástica) O paciente queimado apresenta uma série de alterações metabólicas ocasionadas por uma combinação de liberação de mediadores inflamatórios e descargas hormonais anormais, induzidas pelo estresse, medidas através do eixo hipotalâmico-hipofisário. São alterações metabólicas comuns nas vítimas de queimaduras, EXCETO:
A Oxidação de aminoácidos.
B Pode levar ao “diabetes do estresse”.
C Perda maciça de proteínas pelo organismo.
D Diminuição da lipólise, assim como em outras formas de estresse.
E A área queimada consome grandes quantidades de energia podendo chegar ao dobro do gasto energético basal.

92. (INSTITUTO AOCP - 2019 - Prefeitura de Vitória - ES - Médico Cirurgião Geral) Um paciente de 30 anos, com 70kg, teve queimadura de segundo grau incluindo região de todo o membro superior direito (mão, antebraço e braço anterior e posterior) e região anterior da face e pescoço. De acordo com o diagrama de Berkow para estimativa da extensão da queimadura e de acordo com a fórmula de Parkland para reposição volêmica de queimados, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o cálculo da superfície corpórea queimada estimada e o volume mínimo de hidratação a ser infundido nas primeiras 8 horas para esse paciente.
A 18% e 1260mL.
B 13,5% e 1890mL.
C 13,5% e 945mL.
D 9% e 630mL.

93. (Marinha - 2023 - Comando do 2º Distrito Naval - Oficial Médico) Durante o processo de desgaseificação dos tanques de uma embarcação, ocorreu uma explosão com princípio de incêndio logo em seguida. O médico de plantão no serviço de referência recebeu um militar de 35 anos, 70 kg, com queimadura de segundo grau em 40% da sua superfície corporal. De acordo com a fórmula de Parkland, qual é o volume total de reidratação venosa indicado para esse paciente nas primeiras 24 horas?
A 467 ml.
B 11.200 ml.
C 5.600 ml.
D 2.500 ml.
E 800 ml.

94. (FGV - 2024 - EBSERH - Área de Atuação - Atendimento ao Queimado) Um paciente de 75 kg sofreu queimaduras de 2º e 3º graus na face anterior e posterior do tronco e na face posterior do membro inferior. Usando a fórmula de Parkland, o volume que deverá ser reposto é:
A 6.750 ml de coloides nas primeiras 8 horas;
B 8.000 ml de coloides nas primeiras 24 horas;
C 6.750 ml de cristaloides nas primeiras 8 horas;
D 8.000 ml de cristaloides nas primeiras 24 horas
E 6.750 ml de cristaloides nas primeiras 24 horas.

95. (FGV - 2014 - Prefeitura de Osasco - SP - Socorrista) Em um paciente "grande queimado", a expansão do volume para compensar as perdas decorrentes da lesão na superfície corporal é um ponto que tem grande importância para o tratamento do paciente. A esse respeito, assinale a afirmativa *incorreta*.
A A fórmula de Parkland recomenda 2 a 4 mL x % superfície corporal x peso em kg.

B O débito urinário deve estar situado entre 0,5 a 1 mL/Kg/h.
C Infundir 50% do volume calculado nas primeiras 8 horas.
D Nas 24 horas iniciais, devem ser usados, preferentemente, coloides e diuréticos.
E No trauma elétrico, a diurese deve ser mantida em torno de 1,5 mL/Kg/h.

96. (FACET - 2024 - Prefeitura de Queimadas - PB - Enfermeiro ADAPTADA) Um paciente chega ao pronto-socorro com queimaduras de segundo e terceiro graus em aproximadamente 40% da superfície corporal, após um incêndio residencial. A avaliação inicial inclui a aplicação do Protocolo de Queimaduras e a fórmula de Parkland para a ressuscitação volêmica. Com base nos conhecimentos sobre o manejo inicial de queimaduras extensas, selecione a alternativa correta:
1. A ressuscitação com fluidos deve ser iniciada utilizando a fórmula de Parkland, administrando 4 mL/kg/% de área queimada de Ringer Lactato nas primeiras 24 horas, com metade do volume total dado nas primeiras 8 horas, para garantir uma reposição adequada de fluidos (ABA, 2023).
2. O controle da dor deve ser realizado prioritariamente com opioides intravenosos, dada a absorção rápida e consistente em pacientes com grandes áreas queimadas, minimizando a dor intensa que pode ocorrer (NEJM, 2023).
3. O resfriamento inicial das áreas queimadas com água corrente fria é recomendado nas primeiras horas após o trauma, com a ressalva de monitorar a temperatura corporal para prevenir hipotermia em casos de queimaduras extensas, já que a perda de calor é mais significativa (ABA, 2023).
4. A administração de antibióticos sistêmicos deve ser iniciada imediatamente para todos os pacientes com queimaduras de terceiro grau, para prevenir infecções, uma vez que a pele comprometida aumenta o risco de infecções bacterianas (ABA, 2023).
5. A intubação profilática deve ser fortemente considerada em casos de queimaduras faciais e suspeita de inalação de fumaça, mesmo na ausência de sinais claros iniciais de comprometimento das vias aéreas, devido ao risco de edema progressivo (ATLS, 2023).
A Apenas os itens 1, 2 e 4 são verdadeiros.
B Apenas os itens 1, 2, 3 e 5 são verdadeiros.
C Apenas os itens 2, 3 e 4 são verdadeiros.
D Os itens 1, 3 e 4 são verdadeiros.
E Todos os itens são verdadeiros.

97. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente ANULADA) As lesões cerebrais podem ser divididas em lesões primárias, as que ocorrem no momento do trauma, e lesões secundárias as que resultam de complicações ocorridas após o trauma. De acordo com esta classificação, relacione adequadamente as colunas a seguir
1. Lesão primária.
2. Lesão secundária.
( ) Contusão cerebral.
( ) Tumefação cerebral.
( ) Hematoma subdural agudo.
( ) Lesão axonal difusa da substância branca.
A sequência está correta em
A 1, 1, 2, 2.
B 1, 2, 2, 1.
C 2, 2, 1, 2.
D 2, 1, 1, 1.

98. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente ANULADA) Os sinais de fratura da base do crânio são indicativos de gravidade no trauma cranioencefálico. São sinais clínicos indicativos deste tipo de lesão, EXCETO:
A Miose.
B Otorreia.
C Rinorreia.
D Hemotímpano.

99. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Soldado Operacional) O traumatismo cranioencefálico pode ser definido como qualquer lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, meninges, encéfalo e nos seus vasos decorrentes de um trauma externo. Sobre este tipo de trauma, é INCORRETO afirmar que

A os hematomas intra e extracerebrais são caracterizados como lesões encefálicas focais.
B o indicador clínico mais utilizado para classificar a sua gravidade é a Escala de Coma de Glasgow.
C a presença de linhas de fratura na porção basilar do osso occipital caracteriza fratura de base do crânio.
D as lesões cerebrais primárias são as que decorrem de agressões que se iniciam após o momento do trauma.

100. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente) A pressão intracraniana reflete a relação entre o conteúdo da caixa craniana (cérebro, líquido cefalorraquidiano e sangue) e o volume do crânio, que pode ser considerado constante. O reflexo de Cushing representa uma resposta vasomotora a episódios de isquemia cerebral, resultantes da elevação aguda da pressão intracraniana (PIC). São considerados sinais de elevação rápida da pressão intracraniana, que frequentemente ocasionam herniações cerebrais e óbito:
A Cefaleia, taquicardia e edema de papila.
B Taquicardia, hipotensão arterial e bradpneia.
C Bradicardia, arritmia respiratória e hipertensão arterial.
D Alteração da consciência, hipotensão arterial e taquipneia.

101. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente) Os Traumatismos Cranioencefálicos (TCE) são uma causa importante de mortalidade e morbilidade. O cérebro, quando sujeito a um traumatismo poderá desenvolver um edema, provocando o aumento da Pressão Intracraniana (PIC). Assinale a alternativa dos valores normais da PIC em adultos:
A) < 15 mmHg.
B) 18 a 25 mmHg.
C) 20 a 30 mmHg.
D) > 30 mmHg.

102. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente) Os cuidados com pacientes neurológicos a cada dia são mais explorados e exigem um grande conhecimento por parte dos profissionais. O enfermeiro deve estar atento, pois cuidados inadequados podem piorar o quadro geral do paciente, agravando o quadro neurológico. Quanto ao cuidado de manter o paciente em decúbito a 30°, com a cabeça em posição neutra, alinhada ao tórax, justifica-se para:
A) Evitar tração do cateter.
B) Diminuir o risco de infecção.
C) Detectar interferências nos valores.
D) Evitar estase venosa e facilitar a drenagem venosa do cérebro.

103. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente) O Traumatismo Raquimedular (TRM) é uma lesão traumática definida como um conjunto de situações que comprometem a função da medula espinhal em graus variados de extensão. Sobre o TRM, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Lesão medular incompleta: há alguma função motora ou sensitiva abaixo do nível da lesão.
B) Choque medular: é a perda de todas as funções neurológicas abaixo do nível da lesão medular.
C) Lesão medular completa: as funções motoras e sensitivas estão ausentes abaixo do nível da lesão.
D) Fisioterapia precoce: ainda no período hospitalar, por meio de diferentes técnicas cinesioterapêuticas, não é eficaz nessa fase da doença

104. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Soldado Operacional) O trauma de coluna pode provocar a fratura de uma ou mais vértebras e lesões da medula espinhal. Quando os reflexos abdominais estão abolidos é provável que a lesão da medula ocorreu no nível de:
A) L1-L3.
B) L1-L5.
C) S1-S6.
D) T6-T12.

105. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente ANULADA) As contusões cerebrais podem ser definidas como lesões resultantes da movimentação do encéfalo em

relação ao crânio mediante o impacto causada pela aceleração ou desaceleração brusca do crânio e choque do encéfalo contra as estruturas ósseas. As áreas mais comumente afetadas por essas lesões são as regiões:
A) Basal dos lobos frontais e medial dos lobos temporais.
B) Basal dos lobos frontais e anterior dos lobos temporais.
C) Superolateral dos lobos frontais e medial dos lobos temporais.
D) Superolateral dos lobos frontais e anterior dos lobos temporais.

106. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Enfermeiro Emergencista) A Escala de Glasgow, também conhecida como Escala de Coma de Glasgow (ECG), é uma ferramenta clínica amplamente utilizada para avaliar o estado de consciência de um paciente após um trauma cerebral ou em situações de comprometimento neurológico. Desenvolvida pelo neurocirurgião britânico Sir Graham Teasdale e o neurologista escocês Bryan Jennett em 1974, a ECG oferece uma maneira objetiva e quantitativa de medir a gravidade de uma lesão cerebral com base em três componentes principais: abertura dos olhos, resposta verbal e resposta motora. Sobre o componente Resposta Motora, assinale a alternativa correta.
(A) 5 pontos: o paciente executa comandos motores simples, como apertar a mão ou levantar um dedo.
(B) 4 pontos: o paciente responde de forma flexora à dor (decorticação), onde os membros superiores se flexionam em direção ao corpo.
(C) 6 pontos: o paciente responde de forma localizada à dor, movendo-se de forma apropriada ao estímulo doloroso.
(D) 2 pontos: o paciente responde de forma extensora à dor (descerebração), onde os membros superiores se estendem e os membros inferiores se flexionam.

107. (IDECAN - 2014 - CNEN - Enfermeiro) "Um paciente dá entrada no pronto-socorro com história de crise convulsiva em casa, rebaixamento do nível de consciência, hipertenso e taquicárdico. No exame físico, o enfermeiro aplica a escala de coma de *Glasgow*, que mostra que o paciente apresentava abertura ocular à dor, nenhuma resposta verbal e movimento de retirada ao estímulo doloroso." Quanto ao somatório, pode-se encontrar o seguinte valor:
A 15 (normalidade).
B 4 (estado de coma superficial).
C 11 (estado de coma profundo).
D 12 (estado de coma superficial).
E 7 (estado de coma intermediário).

108. (IDECAN - 2024 - Prefeitura de Mossoró - RN - Fisioterapeuta) Uma pessoa foi encaminhada ao Pronto Socorro após cair de uma escada e ter uma perda momentânea da consciência. Durante o exame físico, foi avaliado o nível de consciência do paciente e observou-se que ele abria os olhos ao estímulo sonoro, apresentava resposta verbal com sons e que, na resposta motora, localizava o estímulo. Assinale a alternativa que indica a escala que foi utilizada na avaliação e a pontuação total deste paciente.
A Escala de Ashworth; 8 pontos.
B Escala de Richmond de Agitação-Sedação; 10 pontos.
C Escala de Coma de Glasgow; 12 pontos.
D Escala de Coma de Glasgow; 8 pontos.
E Escala de Coma de Glasgow; 10 pontos.

109. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Enfermeiro) A avaliação da consciência de um paciente em coma é feita com a Escala de Coma de Glasgow (ECG), que atribui uma pontuação a cada uma das seguintes respostas: Abertura ocular, Resposta verbal, Resposta motora. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.
A) O escore para a Resposta Motora de obedecer a comandos é 5.
B) O escore para a Resposta Verbal confusa é 3.
C) O escore para a abertura ocular espontânea é 3.
D) O escore para a Resposta Motora de flexão normal é 2.
E) O escore para Resposta Verbal com palavras inapropriadas é 3.

110. (IDECAN - 2017 - INCA - Médico Emergencista) Dos achados a seguir, aquele que caracteriza uma menor pontuação na Escala de Coma de *Glasgow* e, consequentemente, pior prognóstico é:
A Resposta motora verbal.
B Resposta motora de retirada.
C Resposta motora de decorticação.
D Resposta motora de descerebração.

111. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Enfermeiro Intensivista Pediátrico) Tendo em vista as diretrizes para o manejo do traumatismo crânio-encefálico (TCE) grave em pacientes pediátricos em terapia intensiva, com foco na prevenção de lesões secundárias, monitorização e suporte hemodinâmico adequado, assinale a alternativa correta.
A Em casos de TCE grave, o uso de hiperventilação profilática é recomendado para todos os pacientes com objetivo de reduzir a pressão intracraniana (PIC), uma vez que a redução de CO2 melhora a perfusão cerebral ao causar vasodilatação.
B A monitorização da pressão intracraniana (PIC) está indicada apenas em pacientes pediátricos com TCE grave que apresentem lesão visível no exame de imagem, sendo desnecessária em casos de lesões difusas sem evidência tomográfica.
C A manutenção de uma pressão arterial média (PAM) adequada é fundamental para garantir a perfusão cerebral, sendo que em pacientes pediátricos com TCE grave, a PAM deve ser mantida acima de valores normais para a idade, visando à prevenção de isquemia cerebral.
D A normotermia deve ser mantida rigorosamente em pacientes com TCE grave, pois a hipertermia está associada ao aumento do metabolismo cerebral e agravamento da lesão secundária. O uso de hipotermia terapêutica é reservado para casos de hipertensão intracraniana refratária.
E No TCE grave pediátrico, soluções hipertônicas ou manitol podem ser usadas para controle da hipertensão intracraniana refratária. O uso de soluções salinas hipertônicas apresenta risco de hipernatremia e está contraindicado.

112. (IDECAN - 2014 - CNEN - Enfermeiro) A hipertensão intracraniana, patologia neurológica conhecida por sua gravidade, poderá levar a uma tríade compensatória de sintomas denominada tríade de *Cushing*. Assinale os sintomas referentes.
A Hipotensão, taquicardia e bradipneia.
B Hipertensão, taquicardia e taquipneia.
C Hipotensão, bradicardia e alteração do ritmo respiratório.
D Hipertensão, taquicardia e alteração do ritmo respiratório.
E Hipertensão, bradicardia e alteração do ritmo respiratório.

113. (IDECAN - 2014 - EBSERH - Médico - Medicina Intensiva) "Paciente, 35 anos, sofre acidente automobilístico e, após traumatismo craniano, complica com hipertensão intracraniaca e tríade de *Cushing*." São sintomas que definem corretamente a tríade de *Cushing*:
A Bradicardia, taquipneia e cefaleia.
B Taquicardia, taquipneia e anisocoria.
C Hipertensão arterial, anisocoria e cefaleia.
D Hipotensão arterial, anisocoria e taquicardia.
E Hipertensão arterial, bradicardia e alteração da frequência respiratória.

114. (IDECAN - 2014 - EBSERH - Médico - Neurologia) São sinais e sintomas que constituem a tríade de *Cushing* na fase final da evolução da hipertensão intracraniana:
A Hipertensão arterial, taquicardia e arritmia respiratória.
B Hipotensão arterial, taquicardia e respiração paradoxal.
C Hipotensão arterial, bradicardia e respiração paradoxal.
D Hipertensão arterial, bradicardia e arritmia respiratória.
E Hipertensão arterial, taquicardia e respiração paradoxal.

115. (IDECAN - 2014 - HUFPE) "Um paciente, 20 anos, foi agredido com uma barra de ferro na cabeça. Deu entrada no pronto-socorro com hálito etílico, contando como foi a briga.

Apresentava sangramento ativo em região parietal esquerda, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Sem déficit neurológico. Durante o atendimento inicial, evoluiu letárgico, com rebaixamento do nível de consciência, anisocoria (pupila E > D) e paresia a D. Hemodinamicamente estável." A melhor hipótese diagnóstica para o caso clínico apresentado é

A lesão axonal difusa pela piora clínica do paciente.

B hematoma subdural agudo, que é mais frequente.

C hematoma intraparenquimatoso porque apresentou rápida piora clínica.

D hematoma epidural, pois houve intervalo lúcido seguido de piora neurológica.

E concussão cerebral parietal, justificando o aparecimento de sinais de hipertensão intracraniana.

116. (FUNATEC - 2024 - Prefeitura de Tucuruí - PA - Odontólogo) Quem é responsável por revisar periodicamente o Regulamento do SUS, conforme o Artigo 2º da PORTARIA Nº 2.048, DE 3 DE SETEMBRO DE 2009:

A Ministério da Saúde.

B Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde.

C Comissão Permanente de Consolidação e Revisão de Atos Normativos.

D Sistema Único de Saúde.

117. (MS CONCURSOS - 2019 - CIAS-MG - Técnico em Enfermagem) O Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, estabelecido por intermédio de Portaria nº 2048/ GM, de 5 de novembro de 2002, define a organização estrutural e funcional dos sistemas, bem como a responsabilidade das _____ esferas gestoras da saúde pública brasileira, refletindo as recomendações da NOAS-SUS 01/02. Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna em branco.

A duas

B quatro

C três

D cinco

118. (PS Concursos - 2025 - Prefeitura de Jacinto Machado - SC - Auxiliar de Regulação) Conforme a Portaria Ministerial nº 2048, as urgências e emergências, a atenção primaria à saúde e o programa de saúde da família; é fundamental que a atenção primária e o Programa de Saúde da Família se responsabilizem pelo acolhimento dos pacientes com quadros agudos ou crônicos agudizados de sua área de cobertura ou adstrição de clientela, cuja complexidade seja compatível com este nível de assistência. Além disso, unidades de saúde de sistemas municipais qualificados para a atenção básica ampliada (PABA) deverão possuir área física especificamente destinada ao atendimento de urgências e sala para observação de pacientes até:

A 6 horas

B 4 horas

C 8 horas

D 12 horas

E Nenhuma das alternativas anteriores

119. (IDESG - 2024 - CONSPNOR - RJ - Operador de Frota - Noite) Os veículos de intervenção rápida são essenciais para a eficiência dos serviços de urgência. Conforme a Portaria nº 2.048/02, qual é a função principal desses veículos, também conhecidos como veículos leves ou de ligação médica?

A Transporte exclusivo de pacientes em estado crítico para hospitais.

B Atuação como ambulâncias para transporte de pacientes crônicos em posição sentada.

C Transporte de médicos para fornecer suporte avançado de vida nas ambulâncias.

D Utilização para transporte de equipamentos médicos grandes e pesados.

120. (IDESG - 2024 - CONSPNOR - RJ - Operador de Frota - Noite) As Unidades Hospitalares de Atendimento em Urgência e Emergência são classificadas. primariamente, segundo a Portaria nº 2.048/02, em Unidades Gerais e Unidades de Referência. Cada uma das duas Unidades apresenta subdivisões.

Nesse sentido, fazem parte das Unidades de Referência:
I. Unidades Hospitalares de Referência em Atendimento às Urgências e Emergências de Tipo I.
II. Unidades Hospitalares Gerais de Atendimento às Urgências e Emergências de Tipo II.
III. Unidades Hospitalares de Referência em Atendimento às Urgências e Emergências de Tipo III.
Está(ão) CORRETA(S):
A I, II e III.
B Apenas I e III.
C Apenas II.
D Apenas III.

121. (IDESG - 2024 - CONSPNOR - RJ - Operador de Frota - Noite Assinale a alternativa que NÃO lista corretamente um equipamento padrão necessário para uma Ambulância Tipo B conforme a Portaria nº 2.048/02.
A Maca articulada com rodas.
B Respirador mecânico de transporte.
C Oxigênio com régua tripla para alimentação do respirador, fluxômetro e umidificador de oxigênio e aspirador tipo Venturi.
D Equipamento de radiocomunicação fixo e móvel.

122. (IBFC - 2022 - SESACRE - Condutor de Ambulância) Os veículos utilizados para transporte de viajantes enfermos ou suspeitos devem possuir minimamente os requisitos, de acordo com o disposto no item 2.1 da Portaria nº 2.048/02. O tipo B é classificado um tipo de ambulância. Assinale a alternativa correta sobre ela.
A Ambulância de transporte
B Ambulância de resgate
C Ambulância de suporte avançado
D Ambulância de suporte básico

123. (IBADE - 2024 - Prefeitura de Ouro Preto do Oeste - RO - Médico Clínico Geral) Os veículos utilizados para transporte de viajantes enfermos ou suspeitos devem possuir minimamente os requisitos contidos no item 2.1 da Portaria nº. 2.048/02 do Ministério da Saúde. Que tipo de veículo deve ser utilizado para o atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos?
A Tipo A
B Tipo B
C Tipo C
D Tipo D
E Tipo E

124. (FCC - 2011 - TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Técnico Judiciário - Enfermagem) Conforme a Portaria nº 2.048/GM/2002 do Ministério da Saúde, para o transporte de um paciente com risco iminente de vida e que necessita de cuidados médicos intensivos, com materiais e equipamentos apropriados para esta função, está indicado a ambulância de
A tipo A e tipo C.
B tipo B e tipo F.
C tipo A e tipo B.
D tipo B e tipo C.
E tipo D e tipo F.

125. (MS CONCURSOS - 2018 - Prefeitura de Jequié - BA) A Portaria nº 2048, de 2002, preconiza que, em relação às atribuições das centrais de regulação de urgências, o médico regulador também tem funções gestoras. Sobre isso, marque a alternativa correta:
A O médico regulador de urgências regulará as portas de urgência, considerando o acesso a leitos como uma primeira etapa que envolverá a regulação médica das transferências inter-hospitalares, bem como das internações.
B Acionar planos de atenção a desastres que estejam pactuados com os outros interventores, frente a situações excepcionais, coordenando o conjunto da atenção médica de urgência.
C Requisitar recursos públicos e privados em situações normais, com pagamento ou contrapartida a posteriori, conforme pactuação a ser realizada com as autoridades competentes.
D Contar com acesso às demais centrais do Complexo Regulador, de forma que possa ter as informações necessárias e o poder de opinar

sobre os locais mais adequados, em relação às suas necessidades.

126. (CISLIPA - 2015 - Enfermeiro) Segundo a NBR 14561, disposto no item 2.1 da Portaria nº. 2.048/02, cujo conteúdo adéqua veículos utilizados no transporte de viajantes enfermos ou suspeitos, foram divididos os transportes em 8 categorias:
TIPO A – Ambulância de Transporte: veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo.
TIPO B – Ambulância de Suporte Básico: veículo destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino.
TIPO C – Ambulância de Resgate: veículo de atendimento de urgências pré-hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com equipamentos de salvamento (terrestre, aquático e em alturas).
TIPO D – Ambulância de Suporte Avançado: veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função.
TIPO F – Embarcação de Transporte Médico: veículo motorizado aquaviário, destinado ao transporte por via marítima ou fluvial. Deve possuir os equipamentos médicos necessários ao atendimento de pacientes conforme sua gravidade.
Veículos de Intervenção Rápida – Estes veículos, também chamados de veículos leves, veículos rápidos ou veículos de ligação médica são utilizados para transporte de médicos com equipamentos que possibilitam oferecer suporte avançado de vida nas ambulâncias do Tipo A, B, C e F.
Outros Veículos – Veículos habituais adaptados para transporte de pacientes de baixo risco, sentados (por exemplo, pacientes crônicos) que não se caracterizem como veículos tipo lotação (ônibus, peruas etc.). Este transporte só pode ser realizado com anuência médica. Na ambulância TIPO D (Suporte Avançado), qual dos itens, a seguir, NÃO será encontrado?
A Bomba de infusão com bateria e equipo.
B Micro-ondas.
C Pinça de Magyll.
D Almotolias com antisséptico

127. (COPESE - UFPI - 2022 - Prefeitura de União - PI - Técnico em Enfermagem) De acordo com a Portaria nº 2.048/02, a ambulância é um veículo exclusivo para transporte de doentes. Em relação à ambulância de suporte avançado de vida no atendimento pré-hospitalar, julgue os seguintes itens:
I. A tripulação da ambulância deve ser constituída por 3 profissionais, sendo um motorista, um enfermeiro e um médico;
II. As ambulâncias são transportes terrestres, aéreos e aquaviários destinados ao tráfego de doentes em estado crítico;
III. As ambulâncias devem dispor somente de materiais e de equipamentos básicos de vida;
IV. Os veículos são destinados ao atendimento e ao transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou em transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos.
Assinale a opção CORRETA.
A Apenas as afirmações I e III estão corretas.
B Apenas as afirmações I e IV estão corretas.
C Apenas as afirmações I; II e IV estão corretas.
D Apenas a afirmação III está correta.
E As afirmações I e III estão erradas.

128. (IDECAN - 2017 - CBMDF - Oficial Combatente) A lesão do aparelho locomotor em superfícies articulares dos ossos formadores da articulação que não estão mais em contato anatômico podendo ocasionar dano grave aos tecidos moles e afetar os

vasos sanguíneos e a cápsula articular denomina-se:
A) Entorse.
B) Luxação.
C) Fratura fechada.
D) Fratura completa.

129. (CESGRANRIO - 2012 - Transpetro - Técnico de enfermagem do trabalho) O estiramento dos ligamentos adjacentes a uma articulação denomina-se
A fratura
B contusão
C luxação
D distensão
E entorse

130. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Técnico de Imobilização Ortopédica) Em relação aos sinais e sintomas, a principal característica clínica de uma luxação é o(a):
A sensação de estalo e recuperação espontânea da articulação.
B deslocamento visível de um osso para fora de sua articulação, com deformidade evidente e perda da função articular.
C crepitação óssea e encurtamento do membro afetado.
D hemorragia intensa e deformidade óssea.
E dor intensa e edema localizado, sem perda de mobilidade.

131. (BIO-RIO - 2015 - Prefeitura de São João da Barra - RJ - Técnico em Enfermagem) Uma lesão de tecido mole produzida por uma pancada rompendo os vasos de pequeno calibre, ocasionando sangramento no tecido, é chamada de:
A fratura fechada.
B contusão.
C luxação de pequeno porte.
D estiramento.
E entorse.

132. (FEPESE - 2017 - SES-SC - Enfermeiro) A luxação caracteriza-se por:
A Torção de uma articulação, em geral com lesão de ligamento.
B Quebra de um osso, com deslocamento da articulação.
C Lesão de ligamento com presença de hematoma e edema.
D Lesão óssea, com exposição dos ossos e ligamentos.
E Deslocamento repentino e duradouro, parcial ou completo de um ou mais ossos de uma articulação.

133. (Prefeitura de Itambaracá - PR - 2020 - Prefeitura de Itambaracá - PR - Enfermeiro) O estiramento ou ruptura de ligamentos de uma articulação decorrente de movimentos além do seu limite habitual é um tipo de trauma chamado de
A entorse.
B fratura.
C contusão.
D luxação.

134. (FAU - 2022 - Prefeitura de Iguatu - CE - Técnico em Enfermagem) É a perda da continuidade óssea:
A Luxação.
B Osteoartrose.
C Fratura.
D Osteomielite.
E Osteossíntese.

135. (Instituto Consulplan - 2023 - SEGER-ES - Analista do Executivo - Educação Física) Diversas lesões acometem o sistema esquelético e muscular. A lesão em que ocorre deslocamento repentino, parcial ou completo, das extremidades dos ossos que compõem uma articulação, provocando dor intensa, limitação nos movimentos, inchaços e hematomas, denomina-se:
A Bursite.
B Fratura.
C Entorse.
D Luxação.
E Tendinite.

136. (IADES - 2014 - EBSERH - Nível Superior - Enfermeiro Assistencial) Acerca das lesões do sistema musculoesquelético, assinale a

alternativa que apresenta a definição de entorse.
A Tração ou laceração muscular.
B Quebra na continuidade do osso.
C Lesão dos ligamentos e de outros tecidos moles em uma articulação.
D Separação das superfícies articulares.
E Separação parcial das superfícies articulares.

137. (FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2013 - CISSUL - MG - Técnico em Enfermagem) Analise o caso: Atendimento a paciente que sofreu queda de muro de 2 metros de altura e apresenta os seguintes sinais importantes: deformação e desalinhamento do braço esquerdo, ruptura da pele, impossibilidade em mover o braço e queixa de dor, creptação durante a palpação. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao trauma apresentado.
A Fratura fechada.
B Fratura aberta.
C Luxação.
D Entorse.

138. (AMEOSC - 2016 - Prefeitura de Palma Sola - SC - Agente de Defesa Civil) Quando existe a fratura de um osso é necessário que esse osso seja imobilizado para que ocorra a sua recuperação. As fraturas de ossos podem ser:
A Fechada quando não houver rompimento da pele, ou aberta (fratura exposta) que ocorre somente com os membros inferiores.
B Fechada quando não houver rompimento da pele, ou aberta (fratura exposta) quando o osso quebrado romper os músculos e a pele.
C Fechada quando não houver rompimento da pele, ou aberta (fratura exposta) que ocorre somente com os membros superiores.
D Fechada quando o osso não quebrar apenas trincar, ou aberta (fratura exposta quando o osso quebrado romper os músculos e a pele.

139. (IBADE - 2020 - Prefeitura de São Felipe D`Oeste - RO - Auxiliar de Serviços Diversos) A fratura é a quebra de um osso. Pode ser completa (quando separa as partes) ou incompleta (fissura). As fraturas denominadas 'abertas' são aquelas em que:
A existe um ferimento no local da fratura, mas o osso não aparece.
B não há solução de continuidade entre pele e osso fraturado.
C há abertura na pele por onde se expõe o osso fraturado.
D o osso fraturado penetra na pele buscando um caminho de saída até rompê-la e retomar o sangramento inicial.
E um osso parte provocando dor, incapacidade de movimento, formando uma área arroxeada ou até mesmo uma deformidade no local em que ocorreu a fratura.

140. (IBADE - 2020 - Prefeitura de São Felipe D`Oeste - RO - Auxiliar de Serviços Diversos) São sintomas de fratura:
A temperatura corporal entre 35ºC e 33ºC; dor ao tentar movimentar o membro afetado; inchaço na área atingida; e dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.
B sensação de frio; alteração da fala ou compreensão; temperatura corporal entre 35ºC e 33ºC; e dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente.
C tremores; alteração na visão (em um ou ambos os olhos); dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente; e incapacidade total ou parcial de movimentos do membro afetado.
D incapacidade total ou parcial de movimentos; dor ao tentar movimentar o local; inchaço na área atingida; e posição anormal do membro atingido (fora da posição anatômica).
E confusão mental; dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente; temperatura corporal entre 35ºC e 33ºC; e dor ao tentar movimentar o membro afetado.

141. (IBADE - 2019 - DEPASA - AC - Técnico Eletricista) José Ailtom, funcionário da uma companhia de saneamento e esgoto, tropeçou a caiu sobre o próprio braço. Seu colega, corretamente, conversou com José Ailtom e pediu para ele manter a calma, e passou a observar se havia outros ferimentos mais graves. Aparentemente, não havia. Entretanto

o socorrista suspeitou de fratura, pois a vítima apresentava os seguintes sintomas:
I- dor intensa.
II- inchaço ou deformação.
III- formação de uma área arroxeada.
IV- sons de crepitação ao movimentar ou incapacidade de movimentar o membro.
V- muita sede.
VI- temperatura alta, acima de 39º.
Dos itens acima mencionados, os que são realmente identificados como presença possível de fratura são apenas:
A I, IV.
B I, IV, V, VI.
C II, III, V, VI.
D I, II, III, IV.
E II, III, IV, V.

142. (INSTITUTO AOCP - 2021 - Prefeitura de João Pessoa - PB - Técnico de Imobilização Ortopédica) O que é uma luxação?
A É quando um osso sai parcialmente de sua posição anatômica correta.
B É a perda da congruência articular, ou seja, quando um osso sai por completo de sua posição anatômica correta.
C É a congruência articular.
D É quando um osso quebra na articulação.
E É quando ocorre uma fratura extra-articular.

143. (IBFC - 2022 - SESACRE - Técnico em Órtese e Prótese Ortopédica) Leia o texto abaixo: "_____ é a lesão traumática exercida sobre uma região do organismo por agente contundente na qual a pele resiste e não perde sua continuidade" Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
A Entorse
B Contusão
C Distensão
D Luxação

144. (IDHTEC - 2023 - Prefeitura de Ilha de Itamaracá - PE - Fisioterapeuta) São característicos dos sinais e sintomas da luxação, EXCETO:
A Dor mesmo imobilizado e em repouso.
B Deformação local
C Diminuição da temperatura (local lesionado mais frio que o resto do corpo)
D Inchaço no local
E Equimose

145. (IBFC - 2024 - Prefeitura de Fortaleza - CE - Técnico em Imobilizações Ortopédicas) Assinale a alternativa correta correspondente à fratura em que o osso se estilhaça em vários fragmentos.
A Cominutiva
B Oblíqua desviada
C Espiral
D Exposta
E Longitudinal

146. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Técnico de Imobilização Ortopédica) No atendimento pré-hospitalar, existem etapas a serem seguidas no atendimento do politraumatizado. A recomendação básica para imobilização de uma fratura nestes pacientes é:
A imobilizar na posição encontrada.
B imobilizar o membro na posição anatômica.
C reduzir a fratura imediatamente.
D colocar gelo e elevar o membro.
E aplicar torniquete próximo à fratura mesmo sem sangramento visível.

147. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Técnico de Imobilização Ortopédica) A conduta mais apropriada no manejo pré-hospitalar de uma luxação de ombro é a:
A realização de movimentos de tração para alinhar o ombro imediatamente.
B aplicação de compressa quente para aliviar a dor e restaurar a articulação.
C administração de anti-inflamatórios e imobilização somente após confirmação médica.
D tentativa imediata de reduzir a luxação no local, mesmo sem assistência médica.
E imobilização do membro na posição em que foi encontrado e encaminhamento para avaliação médica.

148. (Prefeitura do Rio de Janeiro - RJ - 2015 - Assistente Técnico Legislativo - Inspetor de

Segurança) Na fratura fechada e desalinhada de osso longo, deve-se:
A colocar gelo no local e não imobilizar, uma vez que a fratura está desalinhada
B realinhar a fratura bem lentamente e imobilizar o local atingindo a articulação acima e abaixo da lesão
C colocar gelo sobre a área em desalinho e fazer curativo compressivo antes de imobilizar apenas o local da fratura
D imobilizar o local, atingindo a articulação acima e abaixo da lesão, sem realinhar a fratura

149. (Master Consultoria - 2016 - Prefeitura de Coruripe - AL - Bombeiro Civil) Sobre fraturas é incorreto afirmar:
A Apresenta como algumas complicações decorrentes: hemorragias, embolia gordurosa, lesões de vasos sanguíneos e nervos periféricos, infecção e perda da extremidade.
B As fraturas podem ocorrer tanto por mecanismo direto como por mecanismo indireto.
C A imobilização é eficiente contra a dor e o edema.
D Os imobilizadores rígidos são mais eficientes que os imobilizadores moldáveis para a imobilização de extremidades fraturadas.
E Todas as alternativas estão incorretas.

150. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Técnico de Imobilização Ortopédica) As fraturas podem ser classificadas como abertas ou fechadas. A fratura exposta é aquela que:
A apresenta rompimento de uma das corticais óssea.
B apresenta deslocamento articular com perda da congruência.
C apresenta compressão óssea.
D apresenta fragmentação múltipla.
E apresenta rompimento de pele e exposição óssea.

151. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Técnico de Imobilização Ortopédica) Após uma queda, um paciente apresenta dor aguda, deformidade e encurtamento aparente do membro inferior esquerdo. A radiografia confirma uma fratura de fêmur. A principal complicação associada à fratura de fêmur que deve ser considerada no atendimento imediato é:
A infecção local.
B embolia pulmonar.
C hemorragia significativa.
D parestesia em dedos do pé.
E lesão do nervo ciático.

152. (VUNESP - 2015 - HCFMUSP - Enfermagem) O processo de consolidação óssea se dá em seis estágios, que são, respectivamente:
A Atrofia, remodelagem, formação do osso, angiogênese, calcificação e remoção da cartilagem.
B Fasciculação, angiogênese, calcificação da cartilagem, remoção da cartilagem, formação do osso e remodelagem.
C Hipertrofia, hematoma e inflamação, angiogênese, calcificação da cartilagem, remoção da cartilagem e remodelagem.
D Hematoma e inflamação, angiogênese, calcificação da cartilagem, remoção da cartilagem, formação do osso e remodelagem.
E Contração isométrica do osso, formação do osso, angiogênese, calcificação da cartilagem, remodelagem e remoção da cartilagem.

153. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Técnico de Imobilização Ortopédica) O processo de cicatrização óssea é composto por várias fases. A primeira fase que ocorre após uma fratura é:
A formação do novo osso.
B formação do calo ósseo.
C remodelação óssea.
D reparação do tecido mole.
E hematoma.

154. (IDECAN - 2023 - Prefeitura de São Caetano do Sul - SP - Auxiliar de Primeira Infância) No caso de uma emergência traumática, deve-se observar o estado geral do acidentado, procurando lesões mais graves que apresentam ferimento e hemorragia. Nesse caso, a conduta é acalmar o acidentado para que ele não fique em pânico ou apreensivo.

Sobre as assertivas abaixo o procedimento correto é

A Fixar a fratura em pelo menos dois pontos: acima e abaixo das articulações e acima e abaixo da fratura.

B Tentar recolocar o osso fraturado de volta no seu eixo.

C Prender as talas com ataduras ou tiras de pano, apertá-las o suficiente para imobilizar a área, com o devido cuidado para não provocar insuficiência circulatória.

D Imobilizar um membro que não pôde voltar ao seu lugar natural forçando seu retorno.

155. (AMEOSC - 2024 - Prefeitura de Guarujá do Sul - SC - Condutor de Veículos) No caso de fratura não-exposta, o procedimento correto de primeiros socorros é:

A Expor a zona da lesão, verificar se há ferimentos e tentar imobilizar as articulações antes e depois da fratura.

B Verificar se existem ferimentos e, em seguida, mover a articulação afetada para aliviar a dor.

C Deslocar imediatamente a vítima para um local seguro.

D Cobrir o ferimento com gaze ou pano limpo e aplicar pressão para estancar o sangramento.

156. (IDESG - 2024 - Prefeitura de Nova Venécia - ES - Técnico em Imobilização Ortopédica) Um paciente com fratura exposta de tíbia e fíbula é admitido no pronto-socorro. É a medida ideal para a imobilização adequada da fratura antes da radiografia:

A Realizar a redução da fratura manualmente antes da imobilização.

B Imobilizar a fratura com tala gessada, incluindo a articulação do tornozelo.

C Aplicar uma tala improvisada com materiais disponíveis no local.

D Realizar a limpeza e o curativo da ferida antes da imobilização.

157. (FUNCAB - 2012 - MPE-RO - Técnico - Oficial de Segurança Institucional) O primeiro socorro à pessoa que apresenta uma fratura fechada consiste em:

A tapar a ferida com gaze, impedindo a hemorragia.

B arrastar a vítima para ambiente mais iluminado

C aplicar um torniquete no local.

D aplicar gelo ou compressa fria no local.

E imobilizar a região suspeita de fratura.

158. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Técnico de Imobilização Ortopédica) A fratura de úmero é uma lesão comum que envolve a quebra do osso do braço, especificamente o úmero. Essas fraturas podem ocorrer em diversas situações, como quedas, acidentes de trânsito, lesões esportivas ou traumas diretos. A gravidade da fratura pode variar desde fraturas simples, onde o osso não se desloca, até fraturas complexas, que podem envolver múltiplas quebras ou o deslocamento dos fragmentos ósseos. Após o descrito, assinale a alternativa que descreve uma característica ou complicação comum relacionada à fratura do úmero.

A Fraturas do úmero podem causar lesões do nervo radial, resultando em dificuldade para estender o punho.

B A fratura do úmero não requer tratamento, pois cicatriza naturalmente sem intervenção.

C A fratura do úmero é sempre acompanhada de uma fratura do rádio.

D Fraturas do úmero são mais frequentes em crianças do que em adultos.

E O tratamento conservador é sempre a primeira opção para fraturas do úmero, independentemente da gravidade.

159. (IDECAN - 2024 - SES-PB - Técnico de Imobilização Ortopédica) Um paciente com múltiplas fraturas decorrentes de um acidente de carro é diagnosticado com síndrome compartimental. A principal intervenção para evitar complicações graves nesse quadro é:

A confeccionar uma janela no gesso.

B imobilização com gesso para evitar maior trauma.

C administração de anti-inflamatórios para reduzir o inchaço.
D abertura de gesso ou fasciotomia para aliviar a pressão.
E elevação do membro afetado.

160. (VUNESP - 2024 - EsFCEx - Oficial - Patologia) Paciente masculino, 23 anos de idade, sofre acidente de motocicleta com politraumatismo. No pronto-socorro encontra-se consciente e contactando adequadamente. Foi diagnosticado uma fratura cominutiva de fêmur esquerdo. Após 24 h de internação, evolui com convulsão e perda da consciência. Qual das hipóteses a seguir é a mais provável e que explicaria a evolução?
A Embolia gasosa.
B Embolia gordurosa.
C Embolia micótica.
D Ateroembolia.
E Embolia neoplásica.

// HACKEANDO A IDECAN: CBMDF
CONSOLE.LOG(">> ACESSO CONCEDIDO.");

GABARITO

1. B	**5. D**	**10. A**
2. C	**6. E**	**11. C**
3. B	**7. E**	**12. B**
4. A	**8. C**	**13. C**
	9. B	**14. B**

VAR IDECAN = "CBMDF";
IF (IDECAN == "CBMDF") {
ACESSO = "CONCEDIDO";
CONSOLE.LOG(">> IDECAN HACKEADA.");
}

15. C
16. B
17. C
18. B
19. A
20. A
21. A
22. C
23. B
24. C
25. B
26. A
27. A
28. A
29. B
30. A
31. D
32. A
33. C
34. C
35. A
36. C
37. B
38. B
39. D
40. C
41. A
42. C
43. B
44. D
45. D
46. D
47. B
48. A
49. A
50. A
51. A
52. E
53. E
54. C
55. B
56. B
57. B
58. A
59. D
60. E
61. E
62. A
63. B
64. A
65. B
66. D
67. D
68. B
69. B
70. D
71. E
72. C
73. B
74. B
75. C
76. A
77. B
78. E
79. D
80. E
81. B
82. A
83. C
84. A
85. C
86. C
87. E
88. D
89. B
90. D
91. A
92. D
93. C
94. B
95. C
96. D
97. B
98. A
99. D
100.C
101.A
102.D
103.B
104.D
105.B
106.D
107.E
108.E
109.E
110.D
111.C
112.E
113.E
114.D
115.D
116.C
117.C
118.C
119.C
120.B
121.B
122.D
123.D
124.E
125.B
126.B
127.C
128.B
129.E
130.B
131.B
132.E
133.A
134.C
135.D
136.C
137.B
138.B
139.C
140.D
141.D
142.B
143.B
144.C
145.A
146.A
147.E
148.D
149.D
150.E
151.C
152.D
153.E
154.C
155.A
156.C
157.E
158.A
159.D
160.B